Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje de la familia con integrante que requiere valoración y cuidado integral de la persona mayor (vejez) en el entorno hogar.

Gobernación de Boyacá | Salud

Gloria Yaneth Manrique Abril

Secretaria de salud

Candy Samanta Rodríguez Castillo

Directora de Promoción y Prevención

Martín Orlando Barrera Cobos

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Blanca Nubia Vásquez

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Grupo Desarrollador

Lorena Mesa Melgarejo

Enfermera, Magister en Salud Pública, Máster en Economía de la Salud y Doctora en Salud Pública. Secretaria de Salud de Boyacá

Eliana Lucia Gualdron Solano

Médica. Especialista en Medicina Familiar y comunitaria. Docente Programa de Especialidad Medicina Familiar y comunitaria. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Tania Ávila Espitia

Médica. Especialista en Medicina Familiar UPTC. Especialista de apoyo al PSPIC. ESE Hospital Regional de Moniquirá.

Yesmin Angelica Torres Pinzòn

Médica. Especialista en Medicina Familiar. Especialista de apoyo al PSPIC. Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E.

Expertas y expertos participantes

Olga Rocío Márquez Moreno

Especialista en auditoria en salud, Magíster en Enfermería con énfasis en materno infantil y doctoranda en Medicina clínica y Salud Pública. Experta en curso de vida. Programa de enfermería. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Andrés Guerrero Rosero

Psicólogo de la UNAD. Gerontólogo de la Universidad de San Buenaventura

Sandra Teresa Tallez Torrado

Trabajadora social, especialista en derecho de familia, especialista en gestión ambiental y máster universitario en estrategias territoriales y ambientales en el ámbito loca. Profesional especializado Programa envejecimiento y vejez, Subdirección de promoción social. Secretaria de salud de Boyacá.

Maria Jose Adame Pongutá

Psicóloga. Profesional apoyo. *programa envejecimiento y vejez, Subdirección de promoción social. Secretaria de salud de Boyacá.*

Rosa Ojeda Ojeda

Profesional en terapia respiratoria, especialista en gerencia hospitalaria. Profesional apoyo. programa envejecimiento y vejez, Subdirección de promoción social. Secretaria de salud de Boyacá.

Danna Ximena Galan Carvajal

Profesional en terapia física. Profesional apoyo. programa envejecimiento y vejez, Subdirección de promoción social. Secretaria de salud de Boyacá.

María Fernanda Vargas Figueredo

Psicóloga especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional apoyo. programa envejecimiento y vejez, Subdirección de promoción social. Secretaria de salud de Boyacá.

Lizzeth Niño Ayala

Trabajadora social, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialista en Gestión Social y Empresarial y Magíster en Gestión Social Empresarial. Profesional apoyo. programa envejecimiento y vejez, Subdirección de promoción social. Secretaria de salud de Boyacá.

Declaración de conflictos de intereses:

Las personas que participaron en la elaboración, revisión y validación de las presentes Pautas de cuidado basadas en la evidencia fueron invitadas a declarar sus intereses financieros, profesionales, académicos, institucionales y personales que pudieran influir, o percibirse como susceptibles de influir, en el desarrollo de los contenidos y la formulación de las recomendaciones. No se identificaron conflictos de intereses que comprometieran la independencia técnica del proceso de elaboración de este documento.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial:

La herramienta Claude de Anthropic fue utilizada en el presente documento para el proceso de extracción de datos de los textos completos seleccionados en las matrices de síntesis de la información. Su utilización fue complementaria al trabajo del equipo responsable y no sustituyó los procedimientos de búsqueda, selección, análisis crítico e interpretación de la evidencia científica, ni los procesos de deliberación y formulación de las pautas de cuidado. La responsabilidad por la rigurosidad metodológica, la pertinencia de las recomendaciones, la integridad de la información y el contenido final del documento corresponde exclusivamente al equipo humano responsable de su elaboración.

Contenido

1. Introducción 8
2. Objetivos 9
General 9
Específicos 9
3. Alcance 10
Población objetivo 10
Usuarios 10
Ámbito de aplicación 10
Aspectos abordados 10
Aspectos no abordados 11
4. Contexto territorial de la condición de salud 11
Dimensión epidemiológica 11
Dimensión clínica 11
Dimensión territorial y social 12
Enfoques internacionales útiles para la herramienta 12
5. Marco normativo 13
6. Preguntas orientadoras 14
7. Metodología 15
7.1 Priorización de temas 16
7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras. 16
7.3 Búsqueda y selección de la evidencia. 17
7.4 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia. 18
7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión. 18
7.6 Actualización 18
8. Resultados: Síntesis de la evidencia para cada pregunta 19
8.1 Pregunta 1: 19
8.2 Pregunta 2. 25
8.2.1 Dimensión nutricional 26

8.2.2 Dimensión cognitiva y psicológica 29
8.2.3 Dimensión físico-funcional 34
8.2.4 Otras dimensiones clave 37
8.3 Pregunta 3. 39
8.4 Pregunta 4. 42
9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia preliminares para la valoración y cuidado integral de la persona mayor en el entorno hogar, desde el enfoque familiar del PICF 45
9.1 Consideraciones generales para la aplicación las pautas de cuidado basadas en la evidencia. 45
9.2 Pautas pregunta 1. Valoración y clasificación del riesgo 49
9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones para el abordaje oportuno . 53
9.3.1 Dimensión nutricional 53
9.3.2 Dimensión cognitiva y mental 54
9.3.3 Dimensión física-funcional 55
9.3.4 Polifarmacia y seguridad farmacológica 56
9.3.5 Violencia, maltrato, negligencia y sobrecarga del cuidador 57
9.4 Pautas pregunta 3. Criterios de alarma y escalamiento 58
9.5 Pautas pregunta 4. 60
9.6 Acciones integradoras para el plan de cuidado familiar 62
10. Referencias 63
11. Anexos 71
11.1 Anexo 1. Ecuaciones de búsqueda 71
11.2 Anexo 2. Frail 76
11.3 Anexo 3. Estratificación operativa y seguimiento 77

1. Introducción

En Boyacá, la valoración y el cuidado integral de la persona mayor se han convertido en un asunto prioritario de salud pública y de organización del modelo de atención, debido al envejecimiento progresivo de la población y a la creciente proporción de hogares que conviven con multimorbilidad, fragilidad y riesgo de pérdida de autonomía. El ASIS departamental evidencia una transición demográfica sostenida, solo para el 2023 la proporción de personas de 60 años y más aumentó de 14,5% en 2015 a 17,6% en 2023 y mantiene tendencia ascendente, lo que anticipa mayor demanda de cuidados longitudinales en el entorno hogar(1). De manera consistente, el ASIS 2024 muestra aumento del índice de dependencia de mayores de 65 años (de 18 en 2019 a 20 en 2024, con proyección a 22 en 2029), reflejando mayor presión sobre familias y redes de cuidado para sostener autonomía y funcionalidad(2).

Valorar integralmente a la familia con persona mayor hace parte fundamental del abordaje del envejecimiento, desde la perspectiva de cuidado de generación de la salud, el cual se considera un proceso humano que implica cambios heterogéneos en capacidad funcional, cognición, estado nutricional, movilidad y entorno social, con alto riesgo de eventos prevenibles (caídas, descompensaciones de ECNT, polifarmacia y efectos adversos, deterioro cognitivo/depresión, aislamiento, maltrato). La literatura científica respalda que la Valoración Geriátrica Integral (Comprehensive Geriatric Assessment, CGA), un proceso multidimensional e interdisciplinario para identificar problemas médicos, funcionales y psicosociales y construir un plan coordinado, mejora resultados clínicos relevantes. Revisiones sistemáticas han mostrado que, en comparación con la atención habitual, la CGA en contextos hospitalarios y de transición aumenta la probabilidad de que las personas mayores estén vivas y en su hogar y reduce deterioro funcional en ciertos escenarios, lo que justifica adaptar sus principios a la atención primaria y comunitaria, donde se decide gran parte de la prevención del deterioro(3).

En Boyacá, contar con orientaciones basadas en la evidencia para la valoración integral del adulto mayor es una necesidad que se sustenta en el perfil de ECNT y sus complicaciones, altamente concentradas en edades mayores. El ASIS 2024 reporta tasas de mortalidad por subcausas cardiovasculares en 2022, como enfermedades isquémicas del corazón (66,39 por 100.000) y cerebrovasculares (27,43 por 100.000), condiciones que interactúan con fragilidad, dependencia y riesgo de hospitalización evitable(2). En este contexto, el territorio agrega barreras operativas de importancia, por ejemplo, el departamento tiene una red

vial extensa con predominio de vías terciarias, lo cual aumenta tiempos de desplazamiento y dificulta continuidad de controles y seguimiento, haciendo aún más relevante estandarizar intervenciones en el entorno hogar(2).

En el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar (PICF), una herramienta basada en evidencia para la valoración integral del adulto mayor en el entorno hogar busca aportar en la reducción de la variabilidad de la práctica y orientar a los equipos básicos hacia una atención centrada en la visión integral de las dimensiones que en el envejecimiento son propensas a mayores cambios, más que en diagnósticos aislados. En este sentido, y desde la estructura lógica del PICF, la herramienta aporta a al componente de curso de vida vejez de manera directa y a la relación de los componentes de cuidado al cuidador, cuidado familiar y cuidado en red.

Siguiendo los momentos del PICF, se pretende fomentar una práctica estandarizada y basada en la mejor evidencia disponible para responder a la pregunta sobre cómo valorar a la persona adulto mayor en el entorno hogar (funcional, cognitivo-afectivo, nutricional, movilidad/caídas, riesgo social y maltrato, adherencia y seguridad en el uso de medicamentos), cómo estratificar riesgo, qué intervenciones son factibles para prevenir deterioro y promover vejez saludable, y cuándo activar rutas o redes de soporte comunitario.

2. Objetivos

General

Desarrollar orientaciones de cuidado con base en evidencia para soportar las acciones del equipo de salud en el entorno hogar que permitan valorar de manera integral los adultos mayores de la familia para identificar necesidades de promoción de la salud, identificación de riesgos y activación de rutas garantizando continuidad del cuidado y atención oportuna.

Específicos

- ✓ Definir y estandarizar la valoración integral en el entorno hogar de las personas mayores en sus dimensiones funcional, cognitivo-

afectivo, nutricional, riesgo psico-social, adherencia y seguridad en el uso de medicamentos.

- ✓ Establecer intervenciones integrales basadas en evidencia, factibles en el entorno hogar, orientadas a preservar capacidad funcional y autonomía, prevenir deterioro y eventos adversos, con criterios de priorización según nivel de riesgo y apoyos familiares disponibles.
- ✓ Precisar los criterios de alarma y activación de rutas para garantizar oportunidad diagnóstica y terapéutica, articulación con la red de servicios y con apoyos comunitarios y sociales.

3. Alcance

Población objetivo

Familias con persona mayor (≈60+) y/o mayores con discapacidad, fragilidad, multimorbilidad o vulnerabilidad social; incluye familias unipersonales con verificación de cuidador/red.

Usuarios

Equipos básicos del nivel primario y actores de la red de servicios para valoraciones complementarias.

Ámbito de aplicación

Entorno hogar (PICF) orientado a valoración integral inicial por dominios: funcional, cognitivo, nutricional, riesgo psico-social, adherencia y seguridad en el uso de medicamentos, educación a la persona mayor y cuidador, y activación oportuna de redes; consistente con el enfoque de clasificación del riesgo y aplicabilidad en primer nivel.

Aspectos abordados

- Identificación de fragilidad/riesgo funcional, caídas, polifarmacia (verificación), riesgo nutricional, riesgo cognitivo/afectivo, violencia/abandono.
- Plan de cuidado primario concertado con la persona y familia; agencia de cuidado.
- Criterios de remisión y seguimiento.

Aspectos no abordados

Manejo especializado de patologías agudas o crónicas específicas; no reemplaza normativa ni valoración clínica completa individual

4. Contexto territorial de la condición de salud

Dimensión epidemiológica

Boyacá evidencia un proceso sostenido de envejecimiento poblacional que incrementa la proporción de hogares con necesidades de cuidado continuo en el entorno hogar. La proporción de personas de 60 años y más pasó de 14,5% (2015) a 17,6% (2023), con tendencia al aumento hacia 2030 (1). El ASIS 2024 reporta una población estimada de 1.311.983 habitantes y confirma la reducción de los grupos más jóvenes y el crecimiento de adultez y vejez (2). En coherencia, el índice de dependencia de mayores de 65 años aumentó de 18 (2019) a 20 (2024) y se proyecta en 22 (2029), lo que refleja mayor presión sobre familias y redes de apoyo para sostener autonomía y funcionalidad.

Este fenómeno se acompaña de una carga relevante por ECNT y causas cardiovasculares. En 2022, las enfermedades isquémicas del corazón registraron una tasa de 66,39 por 100.000 y las enfermedades cerebrovasculares una tasa de 27,43 por 100.000, condiciones que se concentran en edades mayores y se asocian con discapacidad y dependencia (2) .

Dimensión clínica

Desde un enfoque clínico contemporáneo, el envejecimiento relevante para el cuidado no se define solo por la edad cronológica, sino por la capacidad funcional y su trayectoria. La OMS define envejecimiento saludable como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, resultado de la interacción entre la capacidad intrínseca (atributos físicos y mentales) y el entorno.

En la práctica, esto implica que la valoración integral debe centrarse en dominios que predicen pérdida de autonomía y eventos adversos: funcionalidad (AVD/AIVD), movilidad y riesgo de caídas, estado cognitivo-

afectivo, estado nutricional, redes sociales/soledad, seguridad del tratamiento y polifarmacia, y carga del cuidador cuando aplique.

Para estructurar decisiones clínicas, herramientas como la Clinical Frailty Scale permiten estimar fragilidad integrando función, comorbilidad y deterioro cognitivo, y se usan ampliamente para estratificar riesgo y priorizar intervenciones. De forma complementaria, la evidencia sintetizada por Cochrane sobre Valoración Geriátrica Integral (CGA) respalda que un abordaje multidimensional y coordinado mejora resultados relevantes frente a atención habitual, lo que sustenta la pertinencia de adaptar sus principios a atención primaria y comunitaria (con énfasis en plan de cuidado y seguimiento).

Dimensión territorial y social

El envejecimiento en Boyacá ocurre en un territorio con barreras de accesibilidad que afectan continuidad del cuidado, oportunidad de controles y articulación con servicios especializados. El ASIS 2024 describe una red vial extensa (≈17.415 km) con predominio de vías terciarias (81,3%), lo que incrementa tiempos de desplazamiento y dificulta la integración de zonas rurales y dispersas (por ejemplo, Pisba, Paya, Cubará y Puerto Boyacá)(2) . Estas condiciones aumentan el riesgo de seguimiento irregular, descompensaciones de ECNT, consultas tardías y complicaciones prevenibles, y refuerzan la necesidad de fortalecer la capacidad resolutiva en el entorno hogar.

En paralelo, los reportes del PICF/SIBACOM incluyen indicadores que reflejan la presión social del envejecimiento sobre los hogares. El indicador de dependencia económica cuantifica la carga sobre las personas de 15–64 años para sostener a menores de 15 y mayores de 65; en julio, subredes como la 5 y la 9 presentan valores altos (por ejemplo, 84,4 y 83,8, respectivamente), y el reporte interpreta este patrón como consistente con la tendencia de envejecimiento y con desafíos de sostenibilidad social y económica (4).

Enfoques internacionales útiles para la herramienta

Para operacionalizar el envejecimiento saludable, la OMS propone el enfoque de Integrated Care for Older People (ICOPE), que traduce la noción de capacidad intrínseca y funcional en rutas prácticas para atención primaria y comunidad: detección de declives, identificación de necesidades de apoyo social, elaboración de planes personalizados y

seguimiento. Esta perspectiva es pertinente para el PICF porque orienta la valoración a "lo que la persona puede hacer" y a las condiciones del entorno, facilitando intervenciones factibles en el entorno hogar (movilidad/caídas, nutrición, cognición/ánimo, visión/audición, apoyo al cuidador y articulación con redes comunitarias).

5. Marco normativo

El desarrollo del presente documento tiene en consideración el marco normativo nacional y territorial vigente y en particular las siguientes normas aplicables:

Tabla 1. Normativa aplicable a la herramienta

Norma	Aspecto
Ordenanza 023 de 2010, Departamento de Boyacá	Adopta el Modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar como política pública departamental, base territorial para el PICF y el abordaje familiar/comunitario. (Gobernación de Boyacá)
Ley 1171 de 2007	Establece beneficios para personas adultas mayores, orientados a garantizar derechos y mejorar sus condiciones generales de vida. (Secretaría del Senado)
Ley 1251 de 2008	Norma marco para la protección, promoción, restablecimiento y defensa de los derechos de las personas adultas mayores; orienta políticas, planes y programas sobre envejecimiento y vejez. (Función Pública)
Ley 1276 de 2009	Establece criterios de atención integral del adulto mayor en Centros Vida y regula la destinación de la estampilla para bienestar del adulto mayor. (Función Pública)
Ley 1315 de 2009	Define condiciones mínimas para dignificar la estadía y garantizar atención integral con calidad en centros de protección, centros de día e instituciones de atención a personas mayores. (Función Pública)
Resolución 1378 de 2015	Establece disposiciones para la atención en salud y protección social del adulto mayor, incluyendo atención preferencial, gestión integral del riesgo y coordinación intersectorial. (Forseti)

Resolución 024 de 2017	Define requisitos mínimos esenciales para Centros Vida y directrices de seguimiento, vigilancia y control. (Bogotá Jurídica)
Resolución 055 de 2018	Modifica la Resolución 024 de 2017 e incluye ajustes para Centros Vida y Centros Día para adulto mayor. (Forseti)
Ley 1850 de 2017	Establece medidas de protección al adulto mayor, modifica normas previas y penaliza el maltrato por descuido, negligencia o abandono de personas mayores. (Alcaldía de Bogotá)
Ley 2040 de 2020	Adopta medidas para impulsar el trabajo de personas adultas mayores no pensionadas, promoviendo autonomía y autosuficiencia económica. (Función Pública)
Ley 2055 de 2020	Aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; refuerza autonomía, igualdad, no discriminación, participación, vida digna y protección contra violencias. (Función Pública)
Decreto 681 de 2022	Adopta la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, articulada con la Convención Interamericana y orientada al envejecimiento saludable, vejez digna, autónoma e independiente. (Función Pública)
Resolución 2589 de 2025	Establece criterios para asignación de recursos a ESE y entidades territoriales para acciones sectoriales en salud en el marco del Plan para la Década de Envejecimiento Saludable y la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031. (Supersalud)
Ley 2581 de 2026	Modifica parcialmente las Leyes 1276 de 2009 y 1850 de 2017; fortalece la protección integral de derechos de las personas adultas mayores y la destinación eficiente de recursos para Centros Vida, Centros Día, Centros de Bienestar y programas de atención domiciliaria y comunitaria. (Secretaría del Senado)

Fuente: elaboración propia

6. Preguntas orientadoras

- ✓ ¿Cuáles son las estrategias/instrumentos más adecuados para clasificar riesgo de la persona mayor en hogar las dimensiones: mental, cognitiva, física-funcional y nutricional para guiar

decisiones en el marco del abordaje en el entorno hogar?En personas mayores en el entorno hogar, ¿qué acciones e intervenciones iniciales, estratificadas según nivel de riesgo, han mostrado efectividad y factibilidad para el abordaje temprano de alteraciones en las dimensiones mental, nutricional, cognitiva y física-funcional?

- ¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión nutricional?
- ¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión cognitiva?
- ¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión física-funcional?

- ✓ En personas mayores en el entorno hogar, ¿qué criterios de alarma y de remisión, escalamiento oportuno o activación de redes del cuidado permiten identificar necesidad de intervención temprana y prevenir deterioro clínico-funcional, hospitalizaciones evitables y eventos adversos?
- ✓ En personas mayores que viven en el entorno hogar, según su nivel de fragilidad o riesgo aumentado, ¿qué esquemas estructurados de seguimiento domiciliario y coordinación con servicios de salud, redes comunitarias y apoyo familiar son efectivos y factibles para mantener la funcionalidad, la autonomía, la participación social y el cuidado seguro, y para reducir eventos adversos, hospitalizaciones evitables e institucionalización?

7. Metodología

El desarrollo de esta herramienta se basa en el Manual para el desarrollo de lineamientos técnicos basados en evidencia del IETS (primera edición, 2024) y en el objetivo de consolidar y difundir acciones/indicaciones basadas en la mejor evidencia disponible e integrando experiencia experta y contexto territorial. Así, la metodología se organizó en cuatro momentos: 1. Priorización de temáticas; 2. validación de preguntas con equipo AT-PIC y referentes; 3. búsqueda y selección sistemática de evidencia y síntesis, y 4. construcción de pautas/lineamientos con consenso informal.

7.1 Priorización de temas

El proceso de priorización de temáticas para desarrollar cinco herramientas basadas en evidencia en el marco del PICF inició con una identificación preliminar de problemáticas mediante triangulación de fuentes (seguimiento PICF, cruce con núcleos/respuestas del Plan Territorial de Salud y ASIS), delimitando desde el inicio temas con alta posibilidad de intervención directa por los equipos básicos (acciones clínicas, seguimiento familiar, educación, detección temprana y articulación con RIAS) y excluyendo determinantes estructurales cuyo abordaje principal no es sanitario. Posteriormente, se aplicó una priorización multicriterio con cinco criterios explícitos (magnitud, severidad, inequidad, factibilidad y alineación), con ponderaciones sugeridas (25%, 20%, 20%, 25% y 10%, respectivamente) y un esquema de votación 1–5 con reglas de inclusión/exclusión por acuerdo ≥80%, utilizando una técnica tipo Delphi con calificación ciega por expertas/os.

La priorización se realizó en dos rondas con dos grupos: primero el equipo de Asistencia Técnica del PIC (ronda 1) y luego el equipo de Promoción y Prevención (ronda 2), incorporando además temáticas nuevas sugeridas al final del cuestionario para ser consideradas en la segunda ronda. Finalmente, tras comparar resultados de la segunda ronda, se definieron las cinco temáticas seleccionadas para la vigencia: (i) riesgo cardiovascular familiar, (ii) consumo de riesgo y problemático de alcohol, (iii) salud del cuidador en hogares con dependencia/cronicidad, (iv) valoración y cuidado integral de la persona mayor (vejez) y (v) cuidados en el hogar para familias con recién nacidos y mujeres en posparto.

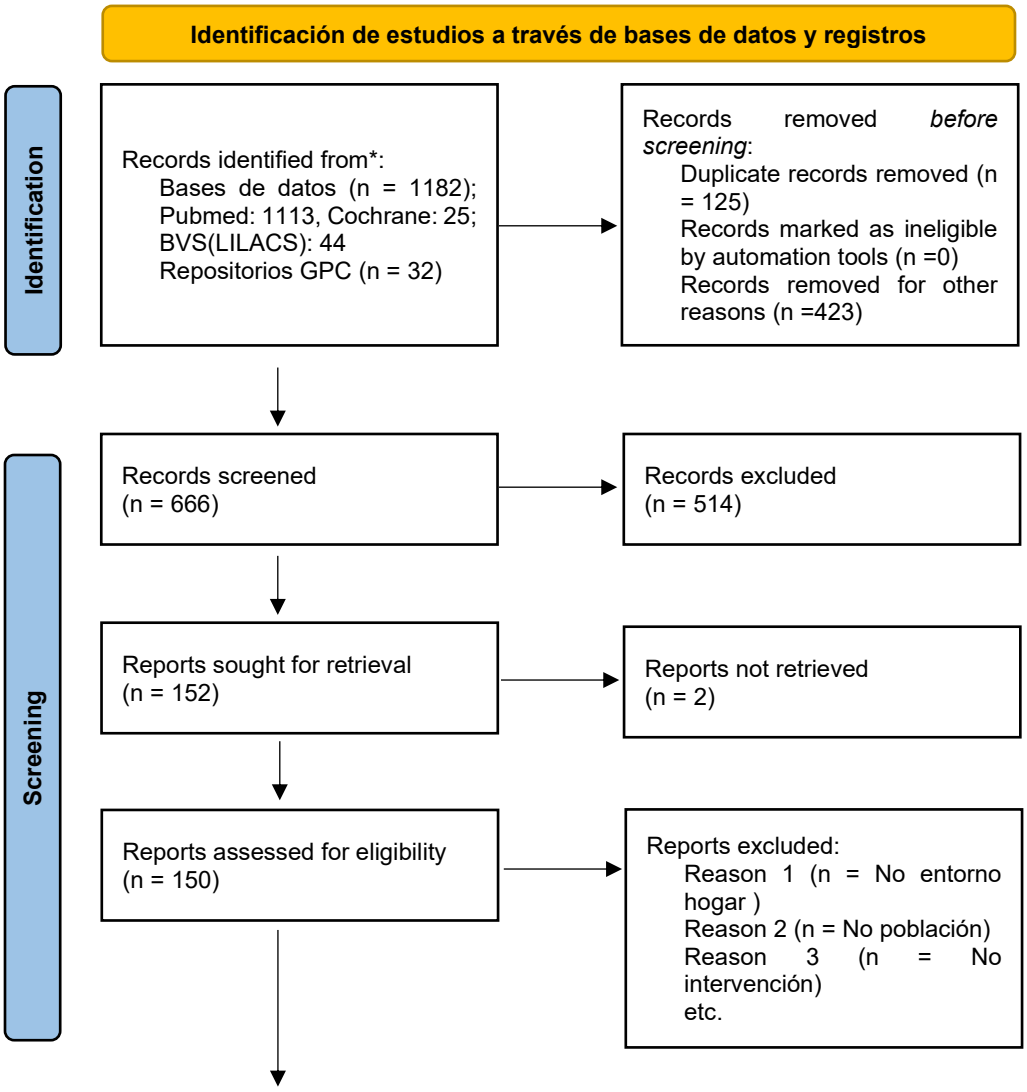
7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras.

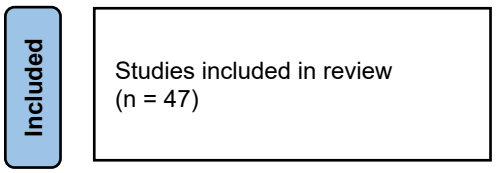
A partir de la triangulación de fuentes sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos y de interacción con algunos equipos de salud, se construyeron las preguntas orientadoras, las cuales se socializaron y validaron con el equipo y referentes por medio de sesiones deliberativas. Este proceso sigue el modelo de lineamientos que contempla reuniones para discutir, ajustar y consensuar alcance y preguntas.

7.3 Búsqueda y selección de la evidencia.

Para responder a cada pregunta, se realizó una búsqueda sistemática estructurando ecuaciones de búsqueda a partir de términos indexados. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: MEDLINE, Cochrane y LILACS, complementada con literatura gris mediante Google Académico (Anexo 1).

La estrategia incluyó (i) una búsqueda para identificar Guías de Práctica Clínica (GPC) recientes y (ii) una búsqueda para identificar revisiones sistemáticas, con búsquedas independientes por pregunta cuando fue necesario. Los criterios de inclusión fueron: evidencia aplicable al entorno hogar, acorde con la población objeto, revisiones sistemáticas de literatura, guías de práctica clínica, consensos basados en la evidencia, publicaciones en inglés o español, sin límite de año. Las RSL se verificaron con la lista de chequeo AMSTAR; AGREE para el caso de las GPC, y ACCORD para el caso de los consensos. El siguiente es el PRISMA de la revisión realizada.





7.4 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia.

La evidencia incluida se resumió en aspectos clave para las intervenciones recomendadas en el entorno hogar para cada pregunta (beneficios/daños, desempeño de instrumentos de estratificación, factibilidad, recursos, equidad, aceptabilidad), privilegiando la organización temática y la síntesis narrativa. Con base en esto y en la experiencia de los expertos participantes, se realizó un proceso de contextualización de la evidencia y se elaboraron pautas preliminares que posteriormente se sometieron a discusión y consenso informal.

7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión.

Las pautas preliminares se discutieron en rondas sincrónicas y asincrónicas con cuatro tipos de actores: 1. Expertas familiaristas vinculadas al proceso de implementación de las unidades de análisis del PIC. 2. Referentes de la secretaria de salud de Boyacá, 3. Equipos territoriales, y 4. Expertos temáticos externos, buscando asegurar pertinencia territorial y aplicabilidad en el entorno hogar. La aprobación de cada pauta se realizó mediante deliberación y acuerdo informal. Durante estos procesos se habilitó la posibilidad de incorporación de evidencia provista por expertos que cumplieran con los criterios de elegibilidad.

7.6 Actualización

Con base en las pautas internaciones de las herramientas basadas en la evidencia, se sugiere incorporar un mecanismo activo o "vivo" de actualización, si esta estrategia no es posible se debe realizar un proceso de actualización cada 5 años.

8. Resultados: Síntesis de la evidencia para cada pregunta

8.1 Pregunta 1:

¿Cuáles son las estrategias/instrumentos más adecuados para clasificar riesgo de la persona mayor en hogar las dimensiones: mental, cognitiva, física-funcional y nutricional para guiar decisiones en el marco del abordaje a la familia en el PICF?

Síntesis de la evidencia:

Se identificaron 11 revisiones sistemáticas de literatura y una guía de práctica clínica que permitían responder la pregunta orientadora. A partir de estos hallazgos se realizó la síntesis de la evidencia.

La evidencia incluida muestra que la valoración integral de la persona mayor en el entorno hogar no debe entenderse como un único instrumento aislado, sino como un proceso estructurado, multidimensional y orientado a la toma de decisiones. En conjunto, los estudios revisados respaldan cuatro ideas centrales: i) la valoración geriátrica integral (CGA) constituye el marco más robusto para organizar la identificación de necesidades y riesgos; ii) la detección de fragilidad es un eje prioritario, pero no existe un marcador único suficiente; iii) la valoración debe complementarse con herramientas breves y dominios específicos, como por ejemplo: nutrición, movilidad/caídas, función, cognición y salud mental; y iv) la utilidad clínica de la valoración depende de su vínculo con los aspectos clave de la familia que fueron identificados en el momento de su caracterización, así como con la articulación de cuidados actuales que se dan al interior de la familia con la persona mayor.

En términos generales, los trabajos de síntesis sobre CGA muestran que la valoración integral tiene una base conceptual y empírica consistente para el abordaje de personas mayores en contextos comunitarios. La revisión Cochrane de Briggs et al. encontró que la CGA comunitaria en personas mayores frágiles y de alto riesgo puede reducir ingresos hospitalarios no planificados, aunque sin efectos claros sobre mortalidad o institucionalización(5). La revisión y metaanálisis más reciente de Hayes et al. refuerza esta dirección, mostrando mejoría del estado funcional, mejor calidad de vida relacionada con la salud, reducción de hospitalizaciones y reducción de mortalidad a más largo plazo cuando la CGA se implementa en el hogar(6). Por su parte, Sum et al. encontró evidencia de mejoría en función, fragilidad/caídas, salud mental,

autopercepción de salud y calidad de vida, aunque con heterogeneidad en los resultados(7). En un nivel más amplio, la umbrella review de Veronese et al.(8) respalda que la CGA tiene efectos favorables en múltiples desenlaces, incluyendo fragilidad física en personas mayores comunitarias. En conjunto, esta línea de evidencia sugiere que la valoración integral no solo sirve para describir necesidades, sino para orientar intervenciones con impacto clínico y funcional.

Adicional a lo anterior, la fragilidad emerge como uno de los constructos más útiles para la identificación temprana de riesgo, pero la evidencia también muestra que no debe abordarse con una lógica reduccionista(9,10). Apostolo et al. identificaron que, entre múltiples medidas de fragilidad, el Frailty Index y la velocidad de la marcha son de las opciones más consistentes por sus propiedades diagnósticas y predictivas, mientras que instrumentos como PRISMA-7 y Timed Up and Go muestran alta sensibilidad, aunque con especificidad moderada(9). De forma convergente, Lee et al. documentaron que, en atención primaria, no existe un biomarcador único, sensible y específico, que permita identificar de forma suficiente la fragilidad(11). Lo que conlleva a que la identificación y clasificación del riesgo en la familia con persona mayor frente a la fragilidad depende de una combinación de hallazgos clínicos, funcionales y contextuales que deben ser analizados por el equipo.

En tercer lugar, la evidencia revisada apoya el uso de instrumentos breves y de dominio específico como parte de una valoración integral escalonada. Craig et al. muestran que EASY-Care tiene buena validez y aceptabilidad para la valoración individual de necesidades en personas mayores de la comunidad, aunque persisten vacíos en confiabilidad y en algunos usos diagnósticos(12). El consenso ICFSR de Ruiz et al. propone justamente una ruta pragmática para atención primaria: tamizaje breve con FRAIL (fragilidad) o ICOPE (capacidad intrínseca), seguido de una evaluación más profunda y derivación a CGA cuando el cribado es positivo. Este enfoque resulta especialmente pertinente para escenarios de entorno hogar donde el tiempo operativo es limitado y se requiere decidir rápidamente quién necesita una valoración más exhaustiva(13). A ello se suma la revisión de O'Caoimh et al., que muestra que existen múltiples instrumentos breves de detección de casos para predecir hospitalización, declive funcional, institucionalización o muerte, aunque ninguno, por sí solo, puede recomendarse como estándar único(14). De nuevo, el mensaje dominante es el valor de una batería corta de tamizaje inicial seguida de evaluación integral.

En cuarto lugar, la evidencia muestra que la identificación de riesgos relevantes debe incorporar dominios específicos con fuerte peso pronóstico. La guía ESPEN destaca que todas las personas mayores deben

tamizarse rutinariamente para riesgo de malnutrición y deshidratación, y que la evaluación nutricional debe ser individualizada y vinculada a intervenciones concretas(15). Esto es especialmente importante en el entorno hogar, donde la reducción de ingesta, la pérdida de peso y la deshidratación pueden pasar inadvertidas. De igual forma, la umbrella review de Beck Jepsen et al. muestra que no existe una prueba única para predecir caídas, pero la velocidad de la marcha y algunas pruebas de doble tarea pueden aportar valor dentro de una evaluación comprensiva. Por tanto, nutrición/hidratación, movilidad/caídas y función física deben quedar explícitamente integrados en la valoración(16).

Tomados en conjunto, los estudios sugieren que la pauta de cuidado basada en la evidencia para la familia con persona mayor en el entorno hogar debería organizar la valoración integral en dos niveles. Un primer nivel, breve, de identificación de riesgo, con preguntas o pruebas rápidas sobre fragilidad, pérdida de peso/apetito, movilidad/caídas, función, cognición y estado de ánimo; y un segundo nivel, de valoración integral estructurada, cuando el tamizaje sea positivo o existan señales de complejidad. El valor de esta estrategia radica en que permite seleccionar a quién profundizar, sin perder la perspectiva multidimensional. Además, la literatura muestra que la valoración es clínicamente más útil cuando se realiza por personal capacitado, se integra con trabajo interdisciplinario y se traduce en un plan de cuidado y seguimiento, más que cuando se limita a una medición aislada.

- **Valoración geriátrica integral en el entorno hogar y estrategia de tamización para su activación**

La valoración geriátrica integral (VGI o CGA, por sus siglas en inglés) debe entenderse no como un instrumento aislado, sino como un proceso clínico estructurado, multidimensional e interdisciplinario orientado a identificar de manera integrada los problemas médicos, funcionales, psicológicos, sociales y ambientales de la persona mayor, con el fin de traducirlos en un plan de cuidado individualizado, coordinado y sujeto a seguimiento y que no debería aplicarse en el entorno hogar de manera genérica y rutinaria. La British Geriatrics Society describe la CGA como un proceso que combina evaluación, formulación de una lista priorizada de problemas, elaboración de un plan personalizado, implementación y revisión periódica.(8,17) En atención primaria y comunitaria, su valor radica en que permite identificar personas mayores con fragilidad, multimorbilidad o riesgo aumentado y coordinar intervenciones tempranas. La evidencia más reciente respalda la aplicabilidad de la CGA en el entorno hogar, especialmente en personas mayores que viven en comunidad y presentan fragilidad, multimorbilidad, deterioro funcional, alta utilización de servicios o necesidades complejas. Una revisión

sistemática y metaanálisis de 2025 encontró que la CGA domiciliaria se asoció con mejoría funcional, mejor calidad de vida relacionada con la salud, menor mortalidad a más largo plazo, menor hospitalización y mayor satisfacción con la atención; en cambio, no mostró beneficios consistentes en todos los desenlaces, como institucionalización o visitas a urgencias(6). De manera complementaria, la revisión Cochrane de 2022 mostró que la CGA en comunidad podría reducir hospitalizaciones no planificadas en personas mayores frágiles o de alto riesgo, aunque con heterogeneidad entre los modelos y con menor claridad para otros desenlaces(5). En conjunto, estos hallazgos sugieren que la VGI es aplicable en el hogar, pero su mayor utilidad se concentra en personas mayores con riesgo aumentado, más que como estrategia universal indiferenciada.

Desde una perspectiva operativa, la implementación de la VGI en el hogar debe estructurarse como un proceso en etapas. En primer lugar, requiere la identificación de personas candidatas, priorizando a quienes presentan fragilidad, multimorbilidad, deterioro funcional, caídas, polifarmacia, hospitalizaciones repetidas, riesgo nutricional, queja cognitiva, aislamiento o alta vulnerabilidad social. En segundo lugar, debe definirse un profesional coordinador del caso, responsable de integrar la información, organizar la intervención y asegurar la continuidad del seguimiento. En tercer lugar, la valoración debe cubrir al menos los siguientes dominios: situación clínica general, síndromes geriátricos, funcionalidad, movilidad, estado nutricional, cognición, salud mental, soporte social, situación del cuidador, ambiente físico del hogar, medicación y preferencias de cuidado. Finalmente, la CGA solo se completa cuando la información recogida se traduce en una lista priorizada de problemas, un plan de cuidado con responsables y tiempos, y un mecanismo de reevaluación. Esta secuencia es consistente con la literatura internacional y con el principio de que la CGA no es un acto diagnóstico aislado, sino una herramienta de organización del cuidado.

En el entorno hogar, la VGI adquiere un valor adicional porque permite observar directamente elementos que no siempre son visibles en una consulta institucional. Entre ellos se encuentran la seguridad del domicilio, los riesgos de caída, la accesibilidad, la organización cotidiana del cuidado, la adherencia real a los tratamientos, la calidad del soporte familiar y comunitario, y las barreras materiales o sociales que condicionan la vida diaria. Esta característica la hace especialmente congruente con enfoques del PICF, en los que la comprensión de la situación de salud depende no solo de la condición clínica individual, sino también de la dinámica familiar, la red de apoyo y las condiciones del entorno. Así, la CGA domiciliaria no solo recoge información clínica, sino

que produce una lectura más ecológica y contextualizada de la vulnerabilidad y de la capacidad de cuidado.

No obstante, la evidencia también muestra que la efectividad de la VGI en casa no depende exclusivamente de la visita domiciliaria, sino de que esta conserve los componentes nucleares de la CGA: evaluación estructurada, competencia geriátrica, trabajo interdisciplinario, plan individualizado y seguimiento. Los ensayos incluidos en las revisiones muestran modelos heterogéneos, algunos predominantemente domiciliarios y otros híbridos, combinando hogar con atención primaria, contacto telefónico o evaluación ambulatoria. Sin embargo, los elementos comunes fueron la presencia de experticia geriátrica, la valoración sistemática, la coordinación del caso y la adaptación del plan al nivel de riesgo y a la situación concreta de la persona y su familia. En este sentido, no cualquier visita al hogar equivale a una CGA, y no toda evaluación en casa tendrá el mismo rendimiento si no se inserta en un modelo organizado de atención.

A partir de esta evidencia, la forma más razonable de implementar la VGI en el entorno hogar es mediante una estrategia de tamización escalonada, en la cual no todas las personas mayores reciban inicialmente una CGA completa, sino que se use primero un tamizaje breve para identificar fragilidad o riesgo aumentado. Esta aproximación es consistente con el consenso internacional sobre fragilidad, que recomienda utilizar instrumentos breves de tamización para seleccionar personas mayores que luego deban ser sometidas a una evaluación geriátrica integral más profunda. También es consistente con la lógica operativa del PICF, que plantea la programación de visitas y la definición de la modalidad de cuidado según criterios de riesgo y vulnerabilidad.

Con base en la opinión de expertos, se considerpo que en el contexto del departamento de Boyacá, la aplicación de una VGI completa en el domicilio puede enfrentar barreras propias de la ruralidad dispersa, como las distancias, la topografía, las dificultades de acceso y la disponibilidad limitada de equipos interdisciplinarios. Por ello, podría considerarse una estrategia escalonada, en la que la VGI completa se reserva para las personas mayores con tamizaje positivo o señales de mayor complejidad, resulta especialmente pertinente para el PICF. Su implementación debe prever ajustes operativos, como la priorización de casos, la programación de visitas según condiciones de accesibilidad y la articulación con otros niveles y modalidades de atención.

La estrategia de tamización propuesta debería comenzar con una preclasificación antes de la visita domiciliaria, utilizando la información disponible en SIBACOM sobre la caracterización de la familia y de sus miembros, historia clínica, reportes familiares y utilización reciente de

servicios. En esta fase, pueden identificarse señales de riesgo como hospitalizaciones recientes, caídas, deterioro funcional, pérdida de peso, polifarmacia, problemas cognitivos o emocionales, sobrecarga del cuidador, vivir solo o disponer de una red débil de apoyo. Esta prelectura permite que la visita al hogar no parta de cero, sino de una hipótesis inicial de complejidad y de la priorización de los casos con mayor vulnerabilidad.

Ya en el domicilio, el tamizaje debe ser breve, factible y orientado a decidir si se requiere una CGA completa. Para ello, la evidencia sugiere combinar un instrumento corto de fragilidad con una prueba física de desempeño y un barrido de dominios clave. Entre las herramientas más útiles se encuentra ICOPE, que permite buscar deterioro de capacidad intrínseca en varias áreas críticas, incluyendo cognición, movilidad, nutrición, visión, audición y depresión. Otra opción es FRAIL, como tamizaje breve de fragilidad. El consenso ICFSR plantea que estas herramientas son adecuadas para identificar personas en riesgo que luego deben ser sometidas a una valoración más amplia y, si corresponde, a CGA. Para la selección final de los instrumentos, el equipo implementador debe considerar, además de sus propiedades, su familiaridad en la práctica local y la disponibilidad de versiones adaptadas o validadas en Colombia.

La tamización domiciliaria debe complementarse con una prueba breve de desempeño físico, dado que la fragilidad y el riesgo de eventos adversos no se expresan únicamente en autoinforme. La velocidad de la marcha es especialmente útil en este punto. La revisión de Abellan van Kan concluye que la marcha a paso usual es un predictor consistente de discapacidad, deterioro cognitivo, institucionalización, caídas y mortalidad en personas mayores que viven en comunidad. Cuando no sea posible medir marcha de manera segura, puede utilizarse una prueba de levantarse de la silla, como la incluida en ICOPE. El objetivo de estas pruebas no es establecer un diagnóstico definitivo, sino identificar si existe deterioro funcional o vulnerabilidad suficiente como para justificar una valoración geriátrica integral en mayor profundidad.

Adicionalmente, la tamización en el hogar debe incluir un barrido intencional de riesgos mayores, especialmente aquellos que tienen alta relevancia pronóstica y alta factibilidad de observación domiciliaria. Entre ellos destacan: antecedente de caídas o casi caídas, pérdida de peso o disminución del apetito, deterioro funcional reciente, cambios en memoria, conducta o ánimo, problemas de medicación, entorno físico inseguro, y ausencia o sobrecarga de apoyo familiar. Estas señales, aunque no constituyen por sí solas una CGA, sí cumplen la función de alertar sobre fragilidad o complejidad y de facilitar la decisión sobre el nivel de acompañamiento requerido.

En términos operativos, la activación de una CGA completa en domicilio puede justificarse cuando se presenta cualquiera de las siguientes condiciones: tamizaje positivo en ICOPE o fragilidad como FRAIL; marcha lenta o prueba de levantarse de la silla alterada; caída reciente; pérdida de peso o riesgo nutricional; deterioro funcional reciente; queja cognitiva o alteración mental/afectiva; polifarmacia problemática; sobrecarga del cuidador; o entorno físico y social claramente inseguro o insuficiente para sostener el cuidado. Este criterio tiene la ventaja de ser clínicamente sensible y coherente con el hecho de que la función del tamizaje no es "diagnosticar fragilidad" con certeza absoluta, sino seleccionar de manera razonable a las personas mayores que requieren una evaluación integral y un plan de cuidado más intensivo.

En consecuencia, para la implementación de la pauta en el entorno hogar, la recomendación más defendible es adoptar un modelo de dos niveles. El primer nivel corresponde a una tamización breve y estandarizada, aplicada en la primera visita o desde la programación extramural, con énfasis en fragilidad, funcionalidad, cognición, salud mental, nutrición, entorno y soporte social. El segundo nivel corresponde a la valoración geriátrica integral completa, reservada para personas mayores con tamizaje positivo o con señales clínicas, funcionales o sociales de riesgo aumentado. Este modelo permite racionalizar el uso del tiempo del equipo, evitar la sobreevaluación innecesaria y, al mismo tiempo, asegurar que las personas con mayor vulnerabilidad reciban una valoración más profunda y un cuidado proporcional a su riesgo.

En síntesis, la evidencia disponible permite sostener que la VGI es aplicable en el entorno hogar y que su implementación debería articularse mediante una estrategia de tamización escalonada. Dicha estrategia debe identificar fragilidad o riesgo aumentado a partir de información previa, tamizaje breve, pruebas simples de desempeño y observación contextual en el domicilio, para luego activar una CGA completa cuando existan hallazgos suficientes de vulnerabilidad clínica, funcional, cognitiva, emocional, familiar o ambiental. Esta forma de implementación es técnicamente consistente con la evidencia internacional, operativamente viable en el entorno hogar y conceptualmente congruente con el enfoque del PICF y con la necesidad de graduar la intensidad del acompañamiento según riesgo y capacidad de cuidado.

8.2 Pregunta 2.

En personas mayores en el entorno hogar, ¿qué acciones e intervenciones iniciales, estratificadas según nivel de riesgo, han mostrado efectividad y factibilidad para el abordaje temprano de alteraciones en las dimensiones mental, nutricional, cognitiva y física-funcional?

Subpreguntas:

¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión nutricional?

¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión cognitiva?

¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión física-funcional?

Síntesis de la evidencia:

8.2.1 Dimensión nutricional

Para responder a esta pregunta se identificaron 6 revisiones sistemáticas de literatura que cumplían los criterios PRISMA y una guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), la síntesis es presentada a continuación.

La evidencia disponible indica que el abordaje temprano de la dimensión nutricional en personas mayores en el entorno hogar debe organizarse como un proceso secuencial que incluya tamizaje, valoración ampliada, intervención individualizada y seguimiento, más que como una decisión centrada únicamente en la prescripción de suplementos. La literatura de tamizaje nutricional en población mayor que vive en la comunidad muestra que el MNA-SF es la herramienta con mejor respaldo global para la identificación inicial de riesgo nutricional, aunque MUST y SCREEN II también cuentan con apoyo empírico(15,18,19).Esta evidencia es consistente con la guía práctica ESPEN, que recomienda que todas las personas mayores sean tamizadas rutinariamente para malnutrición, y que un resultado positivo sea seguido por valoración sistemática, intervención individualizada, monitorización y ajuste del plan.

En cuanto a las intervenciones, la evidencia sugiere que las estrategias multicomponente son más efectivas que las intervenciones nutricionales aisladas cuando el objetivo es modificar tempranamente la trayectoria de fragilidad, deterioro funcional y riesgo nutricional. La revisión de Khor et al. identificó que las intervenciones multifactoriales que combinan educación nutricional y suplementación proteína-energía mejoran el estado de fragilidad y el desempeño físico con mayor frecuencia que la nutrición sola, mientras que el soporte oral mejora peso y estado nutricional principalmente en los estudios que lo utilizaron en personas con compromiso nutricional(20). En la misma dirección, la revisión sistemática de Mareschal et al. concluye que el enfoque más consistente

para prevenir el deterioro funcional en personas mayores que viven en la comunidad es un abordaje multimodal que combine intervención nutricional y ejercicio, especialmente en personas frágiles o sarcopénicas(19).

Esta convergencia es clínicamente importante para la pauta, porque sugiere que las acciones iniciales en el entorno hogar no deberían limitarse a "dar suplemento", sino priorizar la identificación de quién está realmente en riesgo, qué factores están explicando el bajo consumo o el deterioro nutricional, y qué intensidad de intervención requiere cada persona(18,21,22). La guía ESPEN refuerza esta interpretación al señalar que la atención nutricional en geriatría debe ser individualizada, integral y multidisciplinaria, que las restricciones dietarias innecesarias deben evitarse, y que la nutrición oral puede apoyarse con intervenciones de enfermería, educación, consejería nutricional, modificación de alimentos y suplementos orales. Además, recomienda que los suplementos orales se indiquen cuando la consejería dietaria y la fortificación de alimentos no sean suficientes para alcanzar las metas nutricionales, y que, cuando se usen, aporten al menos 400 kcal/día y 30 g o más de proteína al día(15).

Desde una perspectiva operativa, la evidencia permite distinguir varias acciones iniciales factibles en el hogar. La primera es el tamizaje nutricional sistemático para detectar tempranamente riesgo de malnutrición. La segunda es la valoración ampliada de causas potenciales de ingesta insuficiente o deterioro nutricional, incluyendo pérdida de peso, apetito, dificultades para comprar o preparar alimentos, soledad, limitaciones funcionales, problemas de masticación o deglución y carga de enfermedad. Si bien esta valoración ampliada corresponde al ámbito asistencial, debe ser considerada una vez la persona es derivada a la ruta de atención de alteraciones nutricionales; en el ámbito comunitario y domiciliario el enfoque debe ser que el equipo realice el tamizaje y el abordaje inicial, con recomendaciones de alimentación saludable e intervención de los posibles factores de riesgo identificados.

La tercera es la intervención alimentaria de primer nivel, que puede incluir consejería dietaria individualizada, enriquecimiento o fortificación de alimentos, uso de snacks o comidas adicionales, y adecuación de la textura cuando existan problemas de deglución o masticación. La cuarta es la indicación de suplementación oral proteína-energía en personas malnutridas o en riesgo cuando las medidas anteriores no logran cubrir requerimientos, especialmente si existe pérdida de peso o deterioro funcional concomitante. Estas medidas coinciden con la lógica de acción propuesta por ESPEN y con la síntesis de Khor et al., que muestra mejor respuesta de la suplementación proteína-energía en personas ya malnutridas y resultados inciertos para micronutrientes aislados. Para su

aplicación en el contexto local, se recomienda articular el tamizaje con las orientaciones nacionales sobre valoración nutricional de la persona adulta mayor del Ministerio de Salud y Protección Social y documentar las experiencias de uso de la MNA-SF en el país.

La evidencia también aporta elementos para una estratificación por nivel de riesgo. Se recomienda que esta estratificación se base en el resultado del MNA-SF: estado nutricional normal (12–14 puntos), riesgo de malnutrición (8–11 puntos) y malnutrición (0–7 puntos). Las condiciones como: pérdida de peso, deterioro funcional, baja ingesta, entre otras, deben entenderse como factores de riesgo de mayor deterioro que orientan la intensidad de la intervención y la prioridad de derivación. En personas con riesgo leve o incipiente, sin pérdida de peso importante ni deterioro funcional relevante, parecen razonables intervenciones iniciales basadas en tamizaje, educación alimentaria, ajuste de la dieta habitual, mejora del acceso a alimentos y seguimiento cercano. En personas con riesgo moderado o alto, con pérdida de peso, bajo apetito, limitación funcional, fragilidad o sarcopenia, la evidencia favorece un abordaje más intensivo, que combine consejería nutricional, fortificación alimentaria o suplementos orales y, cuando sea posible, ejercicio o entrenamiento funcional. En presencia de disfagia, problemas dentales o gran dependencia para comer, el plan debe incorporar modificaciones de textura, apoyo durante las comidas y vigilancia más estrecha de la ingesta(15). En todos los niveles de riesgo, la valoración nutricional debe incluir un componente social que explore la disponibilidad de recursos económicos para la alimentación, la red familiar y social de apoyo, la capacidad para adquirir y preparar los alimentos y la presencia de soledad o abandono, dado que la malnutrición en la persona mayor se asocia con frecuencia a estas condiciones y su sola identificación no garantiza su resolución. Cuando se identifiquen, el plan de cuidado debe prever la articulación con los programas sociales y de apoyo alimentario disponibles en el territorio.

Por otra parte, la evidencia es menos consistente para recomendar micronutrientes aislados como estrategia principal de abordaje temprano. La revisión de Khor et al. concluye que los resultados son inconclusos para suplementación con micronutrientes en fragilidad y desenlaces relacionados(20), y la revisión de Mareschal et al. tampoco respalda que la suplementación calórica o proteica aislada, sin una estrategia más amplia, sea suficiente para modificar de forma consistente la función o la trayectoria de deterioro en personas mayores que viven en la comunidad(19). En consecuencia, la mejor interpretación para la pauta es que los micronutrientes deben responder a déficits o indicaciones específicas, y no ocupar el lugar central del abordaje inicial. En el entorno

hogar, lo prioritario es reconocer oportunamente a quiénes derivar para valoración y manejo nutricional en el ámbito asistencial.

En síntesis, la evidencia disponible permite concluir que, para el abordaje temprano de la dimensión nutricional en la persona mayor en el entorno hogar, las acciones con mejor sustento son: tamizaje sistemático del riesgo nutricional, valoración integral de causas y gravedad, incluidas las condiciones sociales, familiares y económicas que afectan la alimentación, consejería dietaria individualizada, fortificación o modificación de la alimentación habitual, uso selectivo de suplementos orales proteína-energía y articulación con ejercicio y otras intervenciones funcionales en personas con mayor vulnerabilidad. En contraste, la suplementación aislada, especialmente de micronutrientes, tiene soporte limitado como estrategia principal. Por ello, el componente nutricional de la pauta debería estructurarse como un proceso escalonado, centrado en riesgo, funcionalidad y respuesta al seguimiento, y no como una prescripción uniforme para todas las personas mayores.

8.2.2 Dimensión cognitiva y psicológica

La evidencia revisada a partir de tres revisiones sistemáticas de literatura, permite responder a esta intervención clínica desde dos planos complementarios, el primero, la identificación temprana del deterioro cognitivo en el hogar, y segundo, las intervenciones iniciales no farmacológicas, factibles en el entorno hogar, especialmente en personas mayores con deterioro cognitivo leve o riesgo aumentado. En conjunto, la evidencia no respalda una intervención única ni un instrumento aislado como solución suficiente. Más bien, orienta a estructurar una respuesta escalonada basada en: tamización, confirmación clínica cuando sea necesario, intervención multidominio, participación familiar y seguimiento.

La pregunta clínica no debe entenderse como una pregunta sobre diagnóstico definitivo de demencia en el hogar. La evidencia muestra que las pruebas cognitivas breves, incluidas las remotas o basadas en informante, pueden ser útiles para identificar señales iniciales o seleccionar personas que requieren valoración ampliada, pero no sustituyen la evaluación clínica integral. La revisión Cochrane de Beishon et al. sobre evaluación cognitiva multidominio remota encontró 31 estudios, 19 pruebas diferentes y 3075 participantes; sin embargo, solo siete estudios evaluaron la precisión frente a diagnóstico clínico de demencia. La sensibilidad de las pruebas remotas varió ampliamente entre 26% y 100%, y la especificidad entre 65% y 100%, sin que pudiera recomendarse una prueba superior. Los autores concluyen que la evidencia sobre precisión diagnóstica de pruebas cognitivas por teléfono

o videollamada sigue siendo limitada, y que las reglas de puntuación de pruebas presenciales no necesariamente aplican cuando se adaptan a formato remoto(23). Esta evidencia puede ser particularmente útil cuando existen barreras de acceso, ruralidad, limitaciones de movilidad o necesidad de seguimiento entre visitas, pero los resultados positivos, dudosos o discordantes deben activar valoración presencial, revisión clínica y, cuando corresponda, remisión a servicios de salud.

La evidencia basada en informante también es relevante para el entorno hogar, porque el equipo puede contar con familiares, cuidadores o personas cercanas que conocen el funcionamiento previo de la persona mayor. La revisión Cochrane de Burton et al. sobre IQCODE incluyó tres estudios con 626 personas, todos en contextos hospitalarios específicos. El IQCODE mostró sensibilidad relativamente buena para identificar personas que posteriormente desarrollarían demencia, pero con especificidad limitada, especialmente con puntos de corte más bajos. Los autores señalan que los estudios fueron heterogéneos, con sesgos potenciales y sin base suficiente para hacer recomendaciones firmes para la práctica clínica(24).

Lo anterior sugiere que los instrumentos basados en informante pueden ser útiles cuando se sospecha cambio cognitivo, especialmente si la persona mayor minimiza síntomas o si el equipo necesita reconstruir el curso temporal del deterioro. Sin embargo, no deben utilizarse de forma aislada. Su mayor valor está en complementar la observación del equipo y la valoración funcional: cambios en memoria, manejo de medicamentos, cumplimiento de citas, orientación, toma de decisiones, manejo de dinero, preparación de alimentos, seguridad en casa y capacidad para resolver situaciones cotidianas. No obstante, en el contexto de Boyacá, donde es frecuente que las personas mayores vivan solas o en situación de abandono, no siempre se dispone de un informante confiable. En estos casos, el equipo debe apoyarse en la evaluación directa de la persona mayor mediante instrumentos breves de tamización cognitiva, en la observación de su desempeño en actividades cotidianas y, cuando sea posible, en la información aportada por otros actores de la red comunitaria o de los servicios de salud, y prever la remisión oportuna cuando no se cuente con apoyo interdisciplinario.

En el entorno hogar, como primer filtro se recomienda indagar mediante preguntas orientadoras: cambios recientes de memoria, dificultad para manejar medicamentos o dinero, pérdida de habilidades previamente adquiridas, desorientación y cambios reportados por el familiar o cuidador. Como alternativa inicial breve puede emplearse el cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ), validado al castellano y aplicable en población rural y con bajo nivel educativo(25) . Si el resultado es positivo, la persona

debe referirse o coordinar la atención en el entorno institucional para la aplicación del MMSE y la continuidad del estudio de posibles etiologías, destacando con la familia la importancia del diagnóstico y la intervención oportunos y la no normalización de la queja de memoria como parte del envejecimiento.

En cuanto a intervenciones, la revisión sistemática de Zou et al., la cual evaluó intervenciones de estilo de vida realizadas total o parcialmente en el hogar en personas mayores con deterioro cognitivo leve(26). Incluyó 20 ensayos controlados aleatorizados: cinco multicomponente y quince de componente único. Las intervenciones incluyeron entrenamiento cognitivo, actividad física, dieta, reducción del estrés o combinaciones de estos componentes. Diecinueve estudios reportaron mejorías significativas en al menos un dominio cognitivo después de la intervención, aunque cuatro también reportaron resultados no significativos en alguna dimensión cognitiva. Los autores concluyen que las intervenciones domiciliarias de estilo de vida tienen potencial para mejorar la cognición en personas mayores con deterioro cognitivo leve, pero que se requieren ensayos más grandes y de mayor duración para confirmar los hallazgos(26).

La misma revisión destaca que las intervenciones domiciliarias pueden ser especialmente pertinentes porque reducen costos y barreras de desplazamiento, aumentan accesibilidad y pueden beneficiar a personas mayores con dificultades para asistir a intervenciones presenciales. Este punto es altamente relevante para territorios rurales o dispersos, donde las intervenciones en casa o apoyadas por telemedicina pueden ser más factibles que los programas exclusivamente institucionales.

Desde el punto de vista de la definición de la pauta, la evidencia favorece un enfoque multidominio. Las acciones iniciales más defendibles para el abordaje cognitivo temprano en el entorno hogar son: estimulación cognitiva estructurada, entrenamiento en estrategias compensatorias para la vida diaria, actividad física segura, intervención nutricional cuando haya riesgo, reducción del estrés, fortalecimiento de rutinas, educación familiar y seguimiento(26). La revisión de Zou et al. muestra que las intervenciones incluidas se concentraron principalmente en actividad física, dieta y entrenamiento cognitivo, con algunos estudios de reducción de estrés. Además, el propio marco conceptual de la revisión señala que las intervenciones no farmacológicas y multidominio se asocian con mejorías en memoria, fluidez verbal, función ejecutiva y cognición global en personas con deterioro cognitivo leve(26).

En términos generales y desde la mirada del PICF, la intervención cognitiva en casa debe integrarse al plan de cuidado familiar y a la vida cotidiana. Esto significa trabajar memoria, orientación, atención y función

ejecutiva mediante actividades funcionales: uso de calendarios, organización de medicamentos, listas visibles, rutinas para comidas y sueño, recordatorios de citas, lectura guiada, juegos de atención, conversación estructurada, evocación de historias, tareas domésticas seguras, caminatas con orientación espacial y actividades con significado para la persona mayor. Cuando la persona mayor vive sola o no cuenta con un familiar o cuidador disponible, estas actividades deben adaptarse para favorecer su realización autónoma y segura, y el plan de cuidado debe contemplar la activación de redes comunitarias, sociales e institucionales que complementen o suplan el apoyo familiar.

Adicionalmente, la evidencia muestra que es relevante una orientación de las intervenciones de acuerdo con el riesgo identificado. Para personas mayores con riesgo bajo o sin deterioro cognitivo evidente, la acción inicial debe centrarse en promoción y vigilancia. Esto incluye educación a la persona y la familia sobre señales tempranas de deterioro, mantenimiento de actividad física, participación social, sueño adecuado, alimentación saludable, control de factores de riesgo vascular, revisión de medicamentos que puedan afectar cognición, uso de lentes o audífonos si se requieren, y seguimiento periódico. En este nivel no se justifica una intervención intensiva ni remisión especializada, salvo que aparezcan cambios funcionales o cognitivos progresivos.

Para personas con riesgo aumentado, queja subjetiva de memoria o hallazgos leves en tamización, pero que conservan independencia funcional, la evidencia apoya iniciar intervenciones domiciliarias no farmacológicas. Estas deberían incluir entrenamiento cognitivo o estimulación cognitiva breve, actividad física adaptada, consejería nutricional cuando exista riesgo, reducción del estrés y apoyo familiar para organizar rutinas. En este grupo, el seguimiento debe verificar si hay progresión, estabilidad o mejoría, y debe evaluar si la queja cognitiva se asocia con depresión, ansiedad, aislamiento, polifarmacia, problemas sensoriales o alteraciones del sueño.

La categorización del riesgo cognitivo (probable, leve, moderado o alto riesgo) requiere definir previamente el instrumento utilizado y sus puntos de corte. Por ejemplo, con el cuestionario de Pfeiffer: 0–2 errores, normal; 3–4, deterioro leve; 5–7, moderado; 8–10, grave, admitiendo un error adicional en personas con bajo nivel educativo. Para personas con deterioro cognitivo leve probable o pérdida incipiente de funcionalidad, la pauta debería recomendar intervención multidominio más estructurada. Esto implica plan familiar con metas concretas, participación del cuidador, ayudas externas de memoria, entrenamiento en actividades de la vida diaria, simplificación de rutinas, revisión de seguridad en el hogar, ajuste del entorno para evitar accidentes y coordinación con el nivel primario

para valoración clínica. En este nivel, los instrumentos de tamización o informante sirven para documentar cambios, pero deben complementarse con valoración funcional y clínica.

Para personas con alto riesgo o sospecha de demencia, deterioro acelerado, alteración funcional significativa o cambios agudos, la intervención domiciliaria inicial debe orientarse a seguridad y canalización a atención especializada. Son señales de alarma: confusión aguda, desorientación de inicio reciente, cambios bruscos de conducta, abandono del autocuidado, errores peligrosos con medicamentos, pérdida rápida de independencia, episodios de extravío, agresividad nueva, alucinaciones, somnolencia marcada, caídas asociadas a confusión o incapacidad del cuidador para sostener el cuidado. En estos casos, la prioridad no es iniciar entrenamiento cognitivo domiciliario, sino activar valoración clínica para descartar delirium, infección, deshidratación, evento adverso por medicamentos, depresión severa u otra causa potencialmente reversible.

La evidencia disponible permite concluir que, para el abordaje temprano de la dimensión cognitiva en personas mayores en el entorno hogar, las acciones más pertinentes son aquellas que combinan detección temprana, valoración funcional, participación familiar e intervenciones no farmacológicas multidominio. Las pruebas cognitivas remotas o breves pueden apoyar la identificación inicial de personas con posible deterioro cognitivo, pero no deben considerarse diagnósticas ni reemplazar la valoración clínica. Los cuestionarios basados en informante pueden complementar la evaluación, especialmente para identificar cambios respecto al funcionamiento previo, aunque su especificidad limitada exige interpretación prudente.

Esto es especialmente importante en la dimensión cognitiva, porque el deterioro cognitivo no siempre se expresa como “olvido” en la entrevista. En el hogar puede observarse como desorden en medicamentos, alimentos vencidos, descuido de higiene, dificultad para manejar dinero, pérdida de rutinas, aislamiento, conflictos familiares, dependencia creciente o riesgo de accidentes. Por tanto, la valoración cognitiva debe estar articulada con la valoración funcional, nutricional, farmacológica, emocional, del cuidador y del entorno.

En personas con deterioro cognitivo leve o riesgo aumentado, las intervenciones domiciliarias de estilo de vida, como por ejemplo la actividad física, entrenamiento cognitivo, dieta, reducción del estrés y estrategias multicomponente, muestran potencial para mejorar dominios cognitivos, aunque la certeza aún es limitada y se requieren estudios más robustos. Por ello, la pauta debería recomendar estas intervenciones como acciones iniciales factibles, de bajo riesgo y coherentes con el

entorno hogar, siempre que se integren a un plan de cuidado familiar, se ajusten al nivel de riesgo y se acompañen de seguimiento.

8.2.3 Dimensión físico-funcional

En el marco de esta dimensión se identificaron 23 revisiones sistemáticas que permitieron responder a la subpregunta. En términos generales, la evidencia sobre la dimensión físico-funcional refuerza que, las intervenciones iniciales más útiles no son las acciones inespecíficas ni los componentes aislados sin acompañamiento. El patrón más consistente favorece: 1) ejercicio o entrenamiento en movilidad con componentes de fuerza, equilibrio y funcionalidad; 2) intervenciones multicomponente o multimodales, especialmente en presencia de fragilidad; 3) evaluación y modificación de riesgos de caída en el hogar cuando la persona tiene riesgo elevado; y 4) seguimiento profesional, presencial o remoto, para sostener adherencia y ajustar el plan.

La revisión Cochrane de Treacy et al. aporta evidencia de alta certeza en favor del entrenamiento de movilidad para mejorar la movilidad en personas mayores frágiles que viven en la comunidad, con mejoría clínicamente relevante en la SPPB y con efecto favorable también sobre el funcionamiento global, aunque este último con menor consistencia.(27) De forma convergente, Chase et al. mostraron que las intervenciones supervisadas de ejercicio aeróbico y/o de fuerza mejoran la función física medida por desempeño, y que los efectos son mayores en personas frágiles y cuando la dosis semanal es más alta(28). Neil-Sztramko et al. añadieron, a nivel de umbrella review, que los programas grupales que combinan ejercicio aeróbico y de resistencia, actividad física general y ejercicio mente-cuerpo mejoran función física, balance y fuerza, además de probablemente reducir caídas(29).

La evidencia más reciente sobre fragilidad también es concordante. Sirikul et al. mostraron que el ejercicio multicomponente reduce de manera importante el riesgo de fragilidad física(30). Money et al., en una overview de revisiones, concluyeron que la actividad física con componente de resistencia, al menos dos veces por semana, es la estrategia no farmacológica con respaldo más consistente para revertir o frenar la progresión de la fragilidad física; además, la combinación con nutrición puede añadir beneficio, mientras que la nutrición sola sigue siendo incierta(31). Guan et al. también señalaron que las intervenciones multimodales mejoran la fragilidad con mayor consistencia que las de un solo componente(32).

Un punto clave que emerge en la evidencia es el rol de la supervisión, Yao et al. encontraron que las intervenciones domiciliarias mejoran fragilidad,

fuerza de prensión y salud mental, pero las mejoras en función física se observaron solo en el subgrupo supervisado(33). En sentido complementario, Liang et al. hallaron que el ejercicio domiciliario no supervisado no produjo mejoras significativas en pruebas centrales de función de extremidades inferiores como five sit-to-stand, Timed Up and Go o SPPB(34). En otras palabras, no toda intervención "en casa" es equivalente: los programas domiciliarios exclusivamente autoguiados parecen menos eficaces que aquellos con supervisión, acompañamiento o ajuste profesional. Esquemas estructurados con seguimiento del equipo pueden mitigar las limitaciones de los programas autoguiados.

La evidencia sobre seguridad del entorno también es sólida, pero debe aplicarse con estratificación por riesgo. Clemson et al. mostraron que la reducción de riesgos de caída en el hogar disminuye las caídas cuando se dirige a personas con alto riesgo, pero no cuando se implementa de forma universal en poblaciones no seleccionadas(35). Cheng et al. complementaron este hallazgo al mostrar que las intervenciones más eficaces para prevenir caídas fueron las multifactoriales, seguidas por educación más ejercicio y ejercicio más evaluación/modificación del entorno(36). Esto sugiere que, en personas con antecedentes de caída, hospitalización reciente, necesidad de apoyo para actividades diarias o fragilidad manifiesta, la adaptación del entorno hogar debe ser una acción inicial prioritaria, pero no como estrategia indiscriminada para todas las personas mayores. Para seleccionar a quiénes dirigir estas intervenciones, se recomienda un tamizaje inicial en todas las personas mayores mediante tres preguntas clave:

- ¿ha tenido alguna caída en los últimos 12 meses?
- ¿se siente inestable al estar de pie o caminar?
- ¿tiene preocupación o miedo de caerse?

Una respuesta afirmativa a cualquiera de ellas debe conducir a una evaluación más detallada del riesgo de caída(37).

La revisión Cochrane de Clemson et al. muestra que la reducción de riesgos ambientales en el hogar disminuye la tasa de caídas y el número de personas que caen cuando se orienta a personas con mayor riesgo de base identificado, pero no demuestra beneficio en población general o sin identificación de riesgo(35,38). A ello se suma la revisión de Cheng et al., que ubica a las intervenciones multifactoriales y a las combinaciones de ejercicio con evaluación/modificación de riesgos del hogar entre las opciones más eficaces para prevención de caídas en mayores comunitarios(36).

Otro hallazgo relevante es que no toda intervención domiciliaria tiene la misma efectividad. La revisión de Liang et al. muestra que el ejercicio

domiciliario no supervisado tiene poco o nulo efecto sobre funciones de extremidad inferior, como levantarse de la silla, velocidad de marcha, TUG o SPPB(34). En contraste, la revisión de Yao et al. muestra que las intervenciones domiciliarias pueden mejorar fragilidad, fuerza de prensión y desenlaces de salud mental, pero que los efectos sobre función física aparecen principalmente cuando el componente domiciliario cuenta con supervisión profesional(33). Esta misma dirección es consistente con la revisión de Sirikul et al. y con el overview de Money et al., que respaldan el papel de los programas con ejercicio multicomponente y entrenamiento de fuerza/resistencia para revertir o contener la progresión de la fragilidad física, mientras que los suplementos nutricionales aislados siguen mostrando resultados inciertos(30,31).

Adicionalmente, la evidencia también ayuda a delimitar lo que no parece ser suficiente en términos de intervenciones, al respecto, Mayo-Wilson et al. encontraron que las visitas preventivas domiciliarias generales no generan beneficios consistentes sobre mortalidad, institucionalización, hospitalización o vida independiente, y que sus efectos sobre funcionamiento físico son pequeños y probablemente no clínicamente importantes(39). Del mismo modo, Drahota et al. mostraron que la educación o las intervenciones psicológicas aisladas tienen utilidad limitada como estrategia central para prevenir caídas, aunque el coaching o la entrevista motivacional combinados con educación personalizada pueden aportar algo en reducción de la tasa de caídas(40). Esto indica que las acciones iniciales deben ser activas, focalizadas y funcionales, y no limitarse a visitas generales, información o consejería sin un componente terapéutico estructurado.

En cuanto a factibilidad e implementación, la evidencia permite precisar mejor cómo sostener estas acciones en el entorno hogar. Olanrewaju et al. muestran que la adopción de actividad física en personas mayores mejora con intervenciones agradables, grupales o con soporte cognitivo-conductual, pero que para mantener la actividad a largo plazo suelen requerirse enfoques individualizados y modelados desde teorías del comportamiento(41). Además, van Schooten et al. no aportan evidencia de eficacia terapéutica, pero sí muestran que la televaloración funcional es factible y segura, con buena concordancia para five-times sit-to-stand y Timed Up and Go(42). Esto sugiere que, el seguimiento remoto puede apoyar el monitoreo funcional y la continuidad del cuidado, aunque con cautela para balance y velocidad de marcha.

En conjunto, la evidencia permite proponer una lógica escalonada para el abordaje en el hogar y con la familia de esta dimensión en la persona mayor. En personas con riesgo leve o prefragilidad, pueden priorizarse programas estructurados de ejercicio funcional, con énfasis en fuerza,

equilibrio, movilidad y marcha. En personas con fragilidad establecida o deterioro físico-funcional, conviene priorizar intervenciones multicomponente y supervisadas, que combinen ejercicio, entrenamiento en movilidad, terapia ocupacional o entrenamiento en ADL/IADL, y revisión de riesgos. En personas con alto riesgo de caída, la evaluación y modificación del entorno hogar debe sumarse de manera focalizada(33). Finalmente, al implementarse el plan en casa, la evidencia sugiere que el acompañamiento profesional, la revisión periódica y el monitoreo, sea presencial o remoto, son componentes determinantes para lograr impacto físico-funcional y sostener adherencia.

Por tanto, las acciones iniciales más razonables para la pauta son: ejercicio terapéutico con componente de resistencia y movilidad; entrenamiento funcional o en movilidad cuando el problema predominante es desplazamiento o transferencia; intervención multicomponente en presencia de fragilidad o pérdida de independencia; evaluación y modificación de riesgos de caída en personas de alto riesgo; y seguimiento estructurado para sostener seguridad y adherencia. La evidencia no respalda como estrategia central el ejercicio domiciliario completamente no supervisado, las visitas preventivas generales sin componentes activos, ni la educación aislada[1].

8.2.4 Otras dimensiones clave

De manera indirecta, la evidencia sugiere es clave complementar la visión sobre la valoración e intervención del riesgo en la familia con persona mayor, la cual permite sustentar dos componentes adicionales fundamentales para el abordaje en el entorno hora, primero el de la polifarmacia como parte del cuidado de vejez como problema de seguridad y adecuación terapéutica, y la identificación e intervención inicial del maltrato o violencia hacia la persona mayor en el contexto familiar. Ambos asuntos requieren una lógica común: valoración integral, lectura del sistema familiar, identificación de riesgos, coordinación con servicios y seguimiento.

En polifarmacia, la revisión Cochrane de Cole et al. incluyó 38 estudios con 18.073 personas mayores y evaluó intervenciones orientadas a mejorar el uso apropiado de múltiples medicamentos. La mayoría fueron

[1] Para el desarrollo de los planes de cuidado puede considerarse la estrategia VIVIFRAIL, que propone programas de ejercicio multicomponente en casa adaptados al nivel funcional de la persona mayor (https://vivifrail.com/es/inicio/).

intervenciones complejas de cuidado farmacéutico, revisión de medicamentos, apoyo a la decisión clínica y trabajo multidisciplinario. Sin embargo, la certeza de la evidencia fue baja o muy baja, y los resultados fueron inciertos para adecuación de la medicación, medicamentos potencialmente inapropiados, omisiones de prescripción, problemas relacionados con medicamentos, adherencia, hospitalizaciones y calidad de vida(43). Por tanto, la evidencia no permite afirmar que una revisión de medicamentos, por sí sola, reduzca de manera consistente hospitalizaciones o eventos adversos. Aun así, sí justifica incorporar la revisión estructurada de medicamentos como acción prudente de seguridad en personas mayores con fragilidad, multimorbilidad, caídas, confusión, mareo, somnolencia, mala adherencia, múltiples prescriptores o sospecha de evento adverso farmaclógico. La intervención en hogar no debería formularse como "reducir medicamentos", sino como optimizar la farmacoterapia, diferenciando polifarmacia apropiada de polifarmacia inapropiada(43).

En violencia y maltrato hacia personas mayores, la revisión sistemática de Pabón-Poches et al. identificó nueve programas de intervención en contexto familiar, de los cuales siete reportaron efectividad. Los programas efectivos se caracterizaron por integrar educación y entrenamiento en habilidades de cuidado, autocuidado, afrontamiento, manejo del estrés, comunicación y resolución de problemas(44). Además, abordaron variables mediadoras como ansiedad, depresión y sobrecarga del cuidador, junto con factores protectores como autoeficacia y capacidad de resolver problemas.

Para el abordaje en el hogar, esta evidencia respalda una intervención inicial en el centrada en detección activa, seguridad y fortalecimiento de capacidades familiares. La visita debe explorar signos de maltrato psicológico, físico, financiero, sexual y negligencia; sobrecarga o agotamiento del cuidador; dependencia sin relevo; aislamiento; conflicto familiar; y barreras para el cuidado seguro. Cuando se identifique riesgo o daño, la respuesta no debe limitarse a educación, sino activar rutas de protección, salud mental, trabajo social, redes comunitarias y servicios de salud, según la severidad.

En síntesis, las acciones mejor soportadas para la pauta son: revisión estructurada de medicamentos en personas mayores con polifarmacia o señales de riesgo farmacológico; coordinación de ajustes con servicios clínicos o farmacéuticos; identificación activa de maltrato, negligencia y sobrecarga del cuidador (por ejemplo, mediante la escala de Zarit); educación y entrenamiento familiar en habilidades de cuidado, autocuidado, comunicación, afrontamiento y manejo del estrés; activación de redes de relevo y apoyo comunitario; y remisión inmediata

cuando existan señales de violencia, negligencia grave, delirium, evento adverso por medicamentos, caída reciente o incapacidad del hogar para sostener cuidado seguro.

8.3 Pregunta 3.

En personas mayores en el entorno hogar, ¿qué criterios de alarma y de remisión, escalamiento oportuno o activación de redes del cuidado permiten identificar necesidad de intervención temprana y prevenir deterioro clínico-funcional, hospitalizaciones evitables y eventos adversos?

Síntesis de la evidencia

La evidencia revisada no identifica un conjunto único, universal y validado de "criterios de alarma" específicamente diseñado para personas mayores en el entorno hogar. La evidencia indirecta de los estudios recuperados para las demás preguntas muestra que las señales que deben activar remisión o escalamiento del cuidado se organizan alrededor de dominios de riesgo geriátrico: fragilidad, deterioro funcional, caídas, deterioro cognitivo o mental agudo, riesgo nutricional, problemas por medicamentos, inseguridad del entorno y debilidad del apoyo familiar o comunitario. Por tanto, para esta pauta, los criterios de alarma no deberían formularse como una lista aislada de síntomas, sino como hallazgos clínicos, funcionales, cognitivos, nutricionales, farmacológicos, familiares, del entorno y sociales que indican pérdida de reserva, deterioro agudo o incapacidad del hogar para sostener el cuidado seguro.

La evidencia sobre valoración geriátrica integral respalda esta interpretación. La CGA/VGI se plantea como un proceso multidimensional para identificar riesgos y necesidades, y su utilidad depende de que los hallazgos conduzcan a un plan de cuidado, seguimiento y articulación de servicios(8,17,45). Las revisiones sobre CGA en comunidad y en domicilio muestran beneficios potenciales en funcionalidad, calidad de vida, hospitalizaciones y satisfacción, especialmente cuando se aplica a personas mayores frágiles o con riesgo aumentado, aunque con variabilidad según el modelo de implementación(12).

Desde esta perspectiva, el primer grupo de criterios de alarma corresponde al deterioro funcional o físico-funcional. La evidencia incluida para la dimensión físico-funcional muestra que la fragilidad, la marcha lenta, la reducción de movilidad, las caídas, la dificultad para levantarse de una silla, la pérdida de independencia en actividades básicas o instrumentales y el empeoramiento del desempeño físico son señales

tempranas de mayor vulnerabilidad. La evidencia sobre intervenciones físico-funcionales también muestra que las personas con fragilidad o riesgo de caída requieren acciones más intensivas, supervisadas y, en algunos casos, multifactoriales. Por tanto, desde el hogar deben considerarse señales de alarma: caída reciente, caídas recurrentes, miedo intenso a caer, dificultad nueva para caminar o transferirse, pérdida súbita o progresiva de independencia y deterioro marcado de movilidad(33,46).

Un segundo grupo corresponde a los criterios nutricionales. La evidencia de la subpregunta nutricional respalda una secuencia de tamizaje, valoración e intervención individualizada. La guía ESPEN y las revisiones incluidas señalan que la malnutrición, el riesgo nutricional, la pérdida de peso, la baja ingesta, la deshidratación, la disfagia o la dificultad para alimentarse requieren identificación temprana y escalamiento según severidad(15). En el hogar, deberían considerarse señales de alarma nutricional: pérdida involuntaria de peso, disminución persistente del apetito o de la ingesta, signos de deshidratación, dificultad para masticar o deglutir, dependencia para comer, inseguridad alimentaria y coexistencia de riesgo nutricional con fragilidad o deterioro funcional(18).

Un tercer grupo corresponde a la dimensión cognitiva y mental. La evidencia sobre intervenciones domiciliarias para deterioro cognitivo leve muestra que los cambios cognitivos pueden abordarse mediante intervenciones no farmacológicas, entrenamiento cognitivo, actividad física, dieta y estrategias multidominio; sin embargo, esto aplica sobre todo a deterioro leve o estable. Para efectos de alarma y remisión, el hallazgo crítico no es solo la presencia de queja de memoria, sino el cambio agudo o la pérdida acelerada de funcionamiento cognitivo o mental(40,47,48). En consecuencia, deben activar valoración prioritaria o remisión: confusión aguda, desorientación de inicio reciente, cambios bruscos de conducta, somnolencia o agitación no habitual, empeoramiento rápido de memoria, abandono del autocuidado, síntomas depresivos severos, ideación suicida, aislamiento extremo o incapacidad del cuidador/familia para manejar los cambios(26).

Un cuarto grupo corresponde a la seguridad farmacológica y adherencia terapéutica. Aunque la evidencia de visitas preventivas domiciliarias no muestra beneficios consistentes cuando las intervenciones son genéricas, sí indica que muchos programas incluyen evaluación de problemas no tratados, adherencia, medicamentos y remisión a servicios(43). En personas mayores frágiles, la polifarmacia, la mala adherencia, la duplicidad terapéutica, los efectos adversos y los errores de administración pueden precipitar caídas, confusión, deterioro funcional, urgencias y hospitalizaciones. Por ello, deben considerarse criterios de

remisión o revisión prioritaria: eventos adversos sospechados por medicamentos, mareo o caídas tras cambios terapéuticos, confusión asociada a medicación, automedicación riesgosa, falta persistente de adherencia, duplicidades o imposibilidad familiar de administrar adecuadamente el tratamiento.

Un quinto grupo corresponde al entorno hogar y soporte familiar/comunitario. Esta dimensión es central para el PICF, porque el hogar no es solo el lugar donde ocurre la visita, sino el escenario donde se expresan los determinantes, las capacidades de cuidado, las redes y las condiciones materiales que pueden proteger o agravar el riesgo. El lineamiento técnico del PICF define la visita familiar/domiciliaria como un mecanismo para caracterización, reconocimiento de determinantes, educación, tamizajes en población con riesgo, rehabilitación basada en comunidad, activación de rutas y concertación de compromisos de cuidado(49).

La evidencia sobre seguimiento domiciliario aporta una advertencia importante y es que no basta con visitar el hogar. Las revisiones de Van Haastregt, Bouman y Mayo-Wilson muestran que las visitas preventivas domiciliarias universales o inespecíficas tienen beneficios inconsistentes o pequeños sobre mortalidad, hospitalización, institucionalización, caídas o funcionalidad (39,50,51). En contraste, los modelos más prometedores son aquellos que incorporan evaluación multidimensional, metas concretas, coordinación, seguimiento y acciones diferenciadas según riesgo, como ocurre en los enfoques de readaptación funcional o cuidado restaurativo, aunque la certeza de la evidencia es baja o muy baja.

La siguiente tabla construida a partir de la evidencia indirecta permite anticipar algunas acciones que podrían soportar una pauta de cuidado para la familia con adulto mayor en el entorno hogar.

Tabla 2. Acciones por dimensión para escalamiento del cuidado

Dominio	Criterios de alarma desde el hogar	Acción sugerida
Funcional / movilidad	Caída reciente, caídas repetidas, miedo intenso a caer, dificultad nueva para caminar, levantarse o transferirse, pérdida reciente de independencia en ABVD/AIVD, deterioro rápido de movilidad	Remisión a valoración clínica y funcional; activar fisioterapia/rehabilitación; valorar riesgo de caída y entorno

Cognitivo / mental	Confusión aguda, desorientación reciente, cambio brusco de conducta, somnolencia o agitación no habitual, deterioro rápido de memoria, depresión severa, ideación suicida, abandono del autocuidado	Remisión prioritaria a valoración médica; descartar delirium, infección, deshidratación o evento adverso farmacológico; activar salud mental si aplica
Nutricional	Pérdida de peso involuntaria, baja ingesta persistente, pérdida de apetito, deshidratación, disfagia, dependencia para comer, inseguridad alimentaria, malnutrición asociada a fragilidad	Remisión a valoración nutricional y médica; intervención alimentaria; seguimiento estrecho; activar apoyo familiar/social
Farmacológico	Polifarmacia problemática, errores de administración, duplicidad, automedicación, mareo, caídas, somnolencia o confusión posterior a cambios de medicación, mala adherencia persistente	Revisión prioritaria de medicamentos y evaluación de adherencia; coordinación con médico/enfermería y, donde esté disponible, químico farmacéutico; educación a cuidador
Clínico general	Dolor agudo o no controlado, fiebre persistente, disnea, síncope, deterioro súbito del estado general, infección probable, descompensación de enfermedad crónica	Remisión clínica o activación de urgencias según severidad
Entorno hogar	Barreras físicas graves, riesgo alto de caídas, falta de baño seguro, ausencia de saneamiento básico, agua insegura, hacinamiento, imposibilidad de cumplir prácticas básicas de cuidado	Activar intervenciones sobre entorno, rutas sociales/intersectoriales y seguimiento del plan familiar
Soporte familiar / cuidador	Persona mayor sola con dependencia, cuidador sobrecargado, ausencia de relevo, disfuncionalidad familiar severa, violencia, negligencia o imposibilidad de sostener cuidado seguro	Activar red familiar/comunitaria, trabajo social, protección social o rutas de protección según hallazgo

Fuente: elaboración propia.

8.4 Pregunta 4.

En personas mayores que viven en el entorno hogar, según su nivel de fragilidad o riesgo aumentado, ¿qué esquemas estructurados de seguimiento domiciliario y coordinación con servicios de salud, redes comunitarias y apoyo familiar son efectivos y factibles para mantener la funcionalidad, la autonomía, la participación social y el cuidado seguro, y para reducir eventos adversos, hospitalizaciones evitables e institucionalización?

Síntesis de la evidencia

Para dar respuesta a la pregunta se identificador cuatro revisiones sistemáticas, las cuales muestra que los esquemas de seguimiento domiciliario en personas mayores deben entenderse como intervenciones complejas. Las revisiones sobre visitas preventivas domiciliarias no muestran beneficios consistentes cuando las intervenciones son universales, poco diferenciadas o insuficientemente estructuradas. Van Haastregt et al. encontraron efectos favorables solo en una parte de los ensayos revisados y concluyeron que no existía evidencia clara a favor de la efectividad de las visitas preventivas domiciliarias en personas mayores que viven en comunidad(50).

La revisión y metaanálisis de Mayo-Wilson et al., con 64 estudios y 28.642 participantes, refuerza esta interpretación. Las visitas domiciliarias preventivas no se asociaron con reducciones absolutas relevantes en mortalidad, institucionalización u hospitalización; los efectos sobre caídas, calidad de vida y función física fueron pequeños, inciertos o posiblemente no clínicamente importantes. Los autores concluyen que no se identificaron programas con beneficios consistentes, aunque el reporte deficiente de componentes impide descartar que algunos modelos específicos puedan ser efectivos(39).

En población con peor estado de salud o deterioro funcional, la revisión de Bouman et al. tampoco respalda que la intensidad de visitas, por sí sola, garantice mejores resultados. Esta revisión incluyó programas con al menos cuatro visitas domiciliarias por año y seguimiento mínimo de 12 meses en personas mayores con mal estado de salud; siete estudios fueron considerados de calidad suficiente, pero ninguno mostró efectos favorables significativos sobre mortalidad, estado de salud, uso de servicios o costos(51).

La evidencia sobre readaptación funcional (reablement) introduce un matiz relevante. La revisión Cochrane et al. evaluó servicios domiciliarios temporales, multidisciplinarios, centrados en metas y orientados a recuperar independencia funcional. La certeza de la evidencia fue muy baja, por lo que no se puede apoyar ni refutar su efectividad; sin embargo, los resultados sugieren una posible mejoría pequeña en función

y una posible reducción de necesidad de mayor nivel de cuidado personal(52).

En conjunto, la evidencia no justifica recomendar visitas domiciliarias preventivas universales o inespecíficas como estrategia suficiente para sostener vejez activa y cuidado seguro. La conclusión más fuerte derivada de la evidencia es que el seguimiento domiciliario debe ser selectivo, estructurado y proporcional al riesgo, con: valoración inicial, definición de metas, plan individualizado, coordinación con servicios de salud, articulación con redes comunitarias, participación del cuidador/familia, activación de rutas y seguimiento de resultados. Esta interpretación es coherente con el PICF, que plantea la visita familiar en el entorno hogar como un proceso de caracterización, valoración familiar, concertación de compromisos, educación, activación, acompañamiento y seguimiento.

En términos generales, la evidencia soporta que los esquemas estructurados de seguimiento domiciliario y coordinación pueden ser factibles y pertinentes, pero su efectividad depende de que no se limiten a “hacer visitas”. Deben incorporar componentes activos de coordinación, recuperación funcional, apoyo familiar y articulación comunitaria. La evidencia es más consistente en advertir lo que no debe hacerse como: visitas preventivas genéricas, repetitivas o sin contenido operativo claro, que en confirmar un esquema único óptimo. Por ello, la pauta debería recomendar un modelo mínimo basado en riesgo, metas y continuidad del cuidado, con indicadores de seguimiento sobre funcionalidad, caídas, hospitalizaciones, institucionalización, participación social, calidad de vida y carga del cuidador. Este modelo debería integrarse en una ruta de atención integral para la persona mayor que articule la atención domiciliaria con la atención hospitalaria y con los servicios sociales y comunitarios, como los centros día o centros vida y los centros de bienestar del adulto mayor, en concordancia con la normatividad vigente para la atención de las personas mayores en Colombia.

9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia preliminares para la valoración y cuidado integral de la persona mayor en el entorno hogar, desde el enfoque familiar del PICF

9.1 Consideraciones generales para la aplicación las pautas de cuidado basadas en la evidencia.

- En toda visita domiciliaria a una familia con persona mayor, se recomienda iniciar el abordaje con la verificación del entorno hogar y de las condiciones reales en las que ocurre el cuidado. Esta verificación debe incluir, como mínimo: accesibilidad de la vivienda, riesgos de caída, condiciones del baño, iluminación, pisos, obstáculos, disponibilidad de agua segura, almacenamiento de alimentos y medicamentos, condiciones para preparar y consumir alimentos, posibilidad de movilización dentro del hogar, presencia de ayudas técnicas y disponibilidad de una persona de apoyo. Esta observación no debe realizarse como una inspección aislada, sino como parte de la comprensión integral de la capacidad del hogar para sostener un cuidado seguro, digno y continuo.

- Antes de aplicar instrumentos específicos a la persona mayor, se recomienda revisar y conectar la información disponible de los instrumentos familiares del PICF con la valoración individual. Esta revisión debe considerar la caracterización familiar, composición del hogar, ciclo vital familiar, funcionalidad familiar, redes de apoyo, condiciones socioeconómicas, barreras de acceso, eventos críticos, presencia de cuidadores, sobrecarga del cuidado y antecedentes de riesgo identificados previamente. Si la información familiar muestra vulnerabilidad, disfuncionalidad, aislamiento, pobreza, violencia, ausencia de red o sobrecarga del cuidador, estos hallazgos deben incorporarse a la clasificación de riesgo de la persona mayor y no tratarse como información separada.

- Si durante el inicio de la visita se identifican necesidades clínicas, funcionales, nutricionales, cognitivas, emocionales o sociales en la persona mayor, se recomienda desplegar el enfoque familiar del PICF mediante diálogo con la persona, el cuidador y la familia, identificación de recursos y dificultades del sistema familiar, concertación de compromisos de cuidado y definición de acciones proporcionales al riesgo. El abordaje debe evitar centrarse únicamente en la persona mayor como individuo aislado; debe reconocer quién cuida, cómo se cuida, con qué recursos cuenta la

familia, qué barreras enfrenta, qué redes pueden activarse y qué apoyos deben gestionarse. Cuando los hallazgos superen la capacidad de respuesta familiar, se deben activar rutas de salud, redes comunitarias, apoyos sociales o mecanismos de protección según corresponda. Esta formulación es coherente con la síntesis del lineamiento, que plantea la visita familiar en el entorno hogar como un proceso de caracterización, valoración, educación, activación de rutas, acompañamiento y seguimiento

- La valoración de la persona mayor en el entorno hogar debe realizarse como un proceso integral, escalonado y orientado a la toma de decisiones, y no como la aplicación aislada de un instrumento. La valoración debe integrar la situación clínica, funcional, nutricional, cognitiva, mental, farmacológica, familiar, social, ambiental y de cuidado, con el fin de definir un plan de cuidado familiar proporcional al riesgo identificado (1–4,13).
- En el marco del PICF, la visita domiciliaria a familias con persona mayor debe partir de la caracterización familiar disponible en SIBACOM o en los sistemas de información usados por el equipo, complementarse con la observación directa del hogar y finalizar con compromisos de cuidado, activación de rutas, articulación comunitaria y seguimiento según riesgo (42).
- No se recomienda realizar una valoración geriátrica integral completa de manera indiscriminada a todas las personas mayores en el hogar. Se recomienda una tamización inicial breve y estandarizada, seguida de valoración geriátrica integral ampliada cuando existan hallazgos de fragilidad, deterioro funcional, riesgo nutricional, alteración cognitiva o mental, polifarmacia problemática, inseguridad del entorno, sobrecarga del cuidador o vulnerabilidad social/familiar (1,2,9,10).
- Para facilitar la canalización y coordinación con otros profesionales/entornos o servicios, se recomienda hacer uso del documento de oferta institucional, municipal, social y comunitaria, el cual a su vez debe ser contestemente actualizado.

RUTA DE VALORACIÓN DE LA FAMILIA CON PERSONA MAYOR COMO INTEGRANTE DEL HOGAR:

Paso	Decisión/acción ajustada a la pauta	Instrumentos/insumos sugeridos	Resultado esperado

1. Prelectura y preclasificación familiar	Antes de la visita, revisar la información disponible de la familia y de la persona mayor para formular una hipótesis inicial de riesgo. Considerar antecedentes, hospitalizaciones, caídas, dependencia, polifarmacia, riesgo nutricional, queja cognitiva, salud mental, red de apoyo, sobrecarga del cuidador, funcionalidad familiar y condiciones sociales.	Caracterización familiar PICF, SIBACOM, historia clínica, reportes previos, utilización reciente de servicios, información del cuidador o equipo territorial.	Definir si la visita entra como tamización general, valoración focalizada o caso probable de valoración ampliada desde el inicio.
2. Verificación inicial del entorno hogar	Al llegar al domicilio, observar las condiciones reales en las que ocurre el cuidado: accesibilidad, baño, pisos, iluminación, obstáculos, cama, silla, ayudas técnicas, disponibilidad de alimentos, almacenamiento de medicamentos, agua segura, saneamiento y presencia de cuidador o apoyo efectivo.	Observación estructurada del hogar y diálogo con persona mayor, familia y cuidador.	Identificar si el entorno protege, limita o aumenta el riesgo de caídas, malnutrición, errores de medicación, aislamiento o cuidado inseguro.
3. Tamización breve por dominios críticos	Realizar preguntas o pruebas rápidas para definir qué dominios requieren profundización: fragilidad, funcionalidad/movilidad, nutrición, cognición, salud mental, soporte familiar/social, medicamentos y riesgo de maltrato o negligencia.	Preguntas trazadoras de caídas, pérdida de peso/apetito, dificultad para caminar o levantarse, queja de memoria, cambio conductual, ánimo depresivo, polifarmacia, sobrecarga del cuidador y red de apoyo.	Identificar dominios alterados y seleccionar la batería breve pertinente, evitando aplicar instrumentos sin propósito clínico u operativo.

4. Aplicación de batería breve según riesgo	Aplicar instrumentos breves cuando el tamizaje o la preclasificación sugieran riesgo. No debe entenderse como batería rígida para todas las personas mayores, sino como conjunto mínimo adaptable.	Fragilidad: FRAIL. Nutrición: MNA-SF. Cognición: Pfeiffer u otra prueba breve disponible, complementada con informante. Ánimo: GDS-5 o escala breve disponible. Riesgo social/familiar: Gijón u otro instrumento social/familiar definido por el PICF. Movilidad: velocidad de la marcha, prueba de levantarse de la silla o TUG con cautela.	Obtener resultados por dominio para orientar decisiones, no para reemplazar el juicio clínico ni la valoración integral.
5. Interpretación integrada	Interpretar cada dominio como: sin hallazgo relevante, hallazgo leve que requiere educación y vigilancia, hallazgo positivo que requiere intervención inicial, o hallazgo que exige valoración ampliada/remisión. Integrar los resultados con la situación familiar y el entorno.	Resultados de instrumentos + observación del hogar + juicio clínico + información familiar.	Clasificar el nivel de riesgo de la persona mayor y del sistema familiar de cuidado.
6. Búsqueda activa de alarmas	Verificar si existe alguna alarma clínica, funcional, cognitiva, nutricional, farmacológica, ambiental, social o de maltrato. Ante alarma, no esperar a completar todo el proceso: activar ruta prioritaria.	Criterios de alarma de la pauta: caída reciente, confusión aguda, pérdida funcional rápida, pérdida de peso importante, deshidratación, disfagia, evento adverso por medicamentos, ideación suicida, violencia, negligencia, cuidador incapaz de sostener el cuidado, entorno inseguro grave.	Definir remisión prioritaria, activación de urgencias, salud mental, protección, rehabilitación, nutrición, trabajo social o red comunitaria según severidad.
7. Valoración ampliada dirigida	Si no hay alarma inmediata, pero hay resultado positivo en uno o más dominios, realizar valoración dirigida para precisar causas, severidad, reversibilidad y	Valoración geriátrica integral ampliada o valoración por dominio: funcional, nutricional, cognitiva, mental, farmacológica, familiar/social y ambiental.	Definir problemas prioritarios y objetivos de cuidado realistas.

	capacidad del hogar para responder.		
8. Plan de cuidado familiar	Construir con la persona mayor, cuidador y familia un plan de cuidado proporcional al riesgo. Debe incluir intervención, responsable, compromisos familiares, red de apoyo, ruta activada, fecha de seguimiento y criterios de reevaluación.	Plan Integral de Cuidado Familiar, compromisos de cuidado, rutas de atención, redes familiares/comunitarias, servicios disponibles del territorio.	Pasar de la valoración al cuidado efectivo, evitando que la visita termine solo en registro de hallazgos.
9. Seguimiento y escalamiento	Reevaluar según nivel de riesgo y respuesta al plan. Escalar cuando aparezca nueva alarma, deterioro, incumplimiento por barreras familiares/sociales, fracaso de la intervención o incapacidad del hogar para sostener cuidado seguro.	Seguimiento domiciliario, llamada, visita de control, unidad de análisis, cierre de remisiones, actualización del plan.	Garantizar continuidad, ajuste del plan y cierre efectivo de rutas o apoyos activados.

Elaboración: propia a partir de expertos.

9.2 Pautas pregunta 1. Valoración y clasificación del riesgo

- En toda familia con persona mayor, antes de la visita domiciliaria se recomienda realizar una preclasificación de riesgo con base en la caracterización familiar, historia clínica, reportes familiares, utilización reciente de servicios y condiciones sociales conocidas. Esta preclasificación debe identificar, como mínimo: caídas recientes, dificultad para caminar, hospitalizaciones o urgencias recientes, pérdida de peso, bajo apetito, sospecha de malnutrición, polifarmacia, problemas de adherencia, queja de memoria, desorientación, cambio conductual, dependencia funcional, vivir solo, red de apoyo débil, disfuncionalidad familiar, pobreza estructural, barreras de acceso, aislamiento territorial, sobrecarga del cuidador o necesidad de cuidador externo.

- Si en la preclasificación se identifica una o más señales de riesgo clínico, funcional, nutricional, cognitivo, mental, farmacológico, familiar o social, se recomienda priorizar la visita domiciliaria y orientar la valoración hacia una hipótesis inicial de fragilidad o riesgo aumentado, con el fin de decidir si la persona requiere tamización breve, valoración ampliada o remisión prioritaria.

- En la primera visita domiciliaria a la persona mayor se recomienda realizar una tamización breve de fragilidad o riesgo aumentado, combinando un instrumento corto con observación clínica y funcional. Pueden utilizarse herramientas como FRAIL, para el tamizaje de fragilidad cuando se requiere un tamizaje breve de fragilidad en atención primaria o comunitaria.

- En el contexto de Boyacá, cuando el equipo requiera una herramienta breve de fragilidad y cuente con entrenamiento para su aplicación, se sugiere considerar el uso de una versión validada o adaptada al contexto colombiano, como FRAIL, sin que esto excluya el uso de ICOPE cuando se busque una aproximación más amplia a la capacidad intrínseca.

Ítem FRAIL	Versión culturalmente adaptada sugerida[2]
Fatiga	"En las últimas 4 semanas, ¿se ha sentido cansado o sin fuerzas la mayor parte de los días, incluso para hacer sus oficios o actividades habituales?"
Resistencia	"¿Se le dificulta subir una cuesta, una loma o varios escalones sin parar a descansar y sin que alguien le ayude?"
Deambulación	"¿Se le dificulta caminar una distancia como ir hasta la tienda, la escuela, la iglesia, la casa de un vecino cercano o recorrer varias cuadras, sin ayuda de otra persona?"
Comorbilidad	"¿Un médico o personal de salud le ha dicho que tiene cinco o más enfermedades, como presión alta, diabetes, enfermedad del corazón, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, cáncer, artritis u otras?"
Pérdida de peso	"En el último año, ¿ha bajado de peso sin proponérselo, ha notado la ropa más floja o ha tenido que ajustar la correa o la falda/pantalón?" Si es posible, verificar con peso registrado.
Interpretación:	0 puntos, robusto (sin criterios de fragilidad); 1–2 puntos, prefragilidad; 3–5 puntos, fragilidad.

- La tamización de fragilidad no debe interpretarse como diagnóstico definitivo. Si el resultado del instrumento es positivo, dudoso o

[2] escala breve con evidencia colombiana, que requiere adaptación cultural y verificación operativa en población rural del departamento

discordante con la observación clínica, se recomienda complementar con evaluación funcional, revisión de antecedentes, valoración del entorno y juicio clínico del equipo, dado que no existe un instrumento único con sensibilidad y especificidad suficientes para resolver por sí solo la clasificación de riesgo en la persona mayor.

- En la valoración física-funcional inicial se recomienda iniciar con un tamizaje que permite identificar el riesgo de caídas realizando las siguientes preguntas:
    - ¿ha tenido alguna caída en los últimos 12 meses?
    - ¿se siente inestable al estar de pie o caminar?
    - ¿tiene preocupación o miedo de caerse?
- Se recomienda incluir una prueba breve de desempeño físico, preferiblemente velocidad de la marcha cuando el espacio y la seguridad del hogar lo permitan. Si no es posible medir marcha de manera segura, se puede usar la prueba de levantarse de la silla. Estas pruebas ayudan a identificar discapacidad, riesgo de caídas, deterioro cognitivo, institucionalización y mortalidad, pero deben interpretarse dentro de una valoración multidimensional.
- Las valoraciones de funcionalidad deben ir acompañadas del relacionamiento con la información del entorno, un entorno seguro permitirá en gran medida que la persona mayor conserve la funcionalidad.
- En la valoración nutricional inicial se recomienda realizar tamizaje sistemático de riesgo de malnutrición y deshidratación. Puede utilizarse MNA-SF como herramienta preferente por su respaldo en personas mayores comunitarias; MUST o SCREEN II pueden considerarse cuando el equipo tenga experiencia con ellas. Todo tamizaje positivo debe activar valoración ampliada de causas, gravedad, ingesta, pérdida de peso, hidratación, capacidad para comprar, preparar y consumir alimentos, problemas dentales, disfagia, dependencia para comer e inseguridad alimentaria.
- En la valoración cognitiva inicial se recomienda identificar cambios en memoria, orientación, atención, conducta, toma de decisiones, manejo de medicamentos, cumplimiento de citas, manejo de dinero, seguridad en casa y desempeño en actividades cotidianas, mediante entrevista a la persona mayor, entrevista a un informante calificado y observación directa del hogar. Las pruebas breves, remotas o basadas en informante pueden apoyar la identificación inicial, pero no deben utilizarse como diagnóstico definitivo de demencia.

- En la valoración mental se recomienda explorar síntomas depresivos, ansiedad, aislamiento, pérdida de interés, cambios del sueño, irritabilidad, desesperanza, ideación suicida, sobrecarga emocional del cuidador y cambios recientes del comportamiento. Para el tamizaje de síntomas depresivos puede emplearse la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage en su versión corta de cinco preguntas. Si se identifican síntomas severos, ideación suicida, abandono del autocuidado o incapacidad familiar para manejar los cambios, se debe activar valoración clínica o ruta de salud mental según severidad.
- La valoración de la persona mayor en el hogar debe incluir una revisión intencionada del uso de medicamentos. Si la persona usa múltiples medicamentos, tiene varios prescriptores, presenta mareo, somnolencia, caídas, confusión, mala adherencia, errores de administración o automedicación, se recomienda activar revisión estructurada de medicamentos con el equipo clínico o farmacéutico disponible. La finalidad debe ser optimizar la farmacoterapia, no simplemente reducir el número de medicamentos.
- La valoración integral debe incluir observación del entorno hogar: barreras físicas, iluminación, pisos, baño, cama, sillas, escaleras, presencia de tapetes u obstáculos, almacenamiento de medicamentos, disponibilidad de alimentos, acceso a agua segura, saneamiento, hacinamiento, accesibilidad y capacidad real del hogar para sostener el cuidado seguro. Si se identifican riesgos ambientales o sociales graves, se debe activar intervención familiar, comunitaria o intersectorial según corresponda.
- Se recomienda activar una valoración geriátrica integral ampliada cuando se identifique cualquiera de las siguientes condiciones: tamizaje positivo en FRAIL o ICOPE, marcha lenta, prueba de levantarse de la silla alterada, caída reciente, miedo importante a caer, pérdida de peso, bajo apetito, sospecha de malnutrición, deterioro funcional reciente, polifarmacia problemática, mala adherencia, queja cognitiva, alteración mental o ánimo depresivo, cuidador sobrecargado, ausencia de apoyo suficiente, entorno inseguro o condiciones sociales muy vulnerables.
- La valoración geriátrica integral ampliada debe culminar en una lista priorizada de problemas, un plan de cuidado familiar individualizado, responsables definidos, tiempos de seguimiento, rutas activadas y criterios de reevaluación. Una visita que solo identifica hallazgos, pero no produce plan, articulación y seguimiento, no debe considerarse una valoración geriátrica integral completa.

9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones para el abordaje oportuno

9.3.1 Dimensión nutricional

- Si la persona mayor no presenta pérdida de peso, bajo apetito, dificultad para comer ni deterioro funcional, se recomienda realizar educación alimentaria básica, promoción de alimentación variada y suficiente, vigilancia periódica del peso, revisión de acceso a alimentos y orientación a la familia sobre signos tempranos de riesgo nutricional. No se recomienda suplementación nutricional de rutina en personas sin riesgo nutricional identificado.
- Si se identifica riesgo nutricional leve o incipiente, se recomienda realizar consejería dietaria individualizada, revisar horarios y cantidad de comidas, promover alimentos de alta densidad nutricional disponibles en el hogar, fortalecer la alimentación habitual, mejorar acceso familiar o comunitario a alimentos y programar seguimiento para verificar ingesta, peso y funcionalidad.
- Si se detecta pérdida involuntaria de peso, disminución persistente del apetito, bajo consumo de alimentos, fragilidad, sarcopenia o deterioro funcional asociado, se recomienda realizar valoración nutricional ampliada, identificar causas modificables, iniciar fortificación de alimentos o comidas adicionales, promover aporte adecuado de proteína y energía, y articular la intervención nutricional con ejercicio o entrenamiento funcional cuando sea posible.
- Si la consejería dietaria y la fortificación de alimentos no permiten alcanzar metas nutricionales, o si existe malnutrición o riesgo nutricional moderado/alto, se recomienda considerar suplementos orales proteína-energía como complemento de la alimentación habitual. Cuando se indiquen suplementos, estos deben aportar al menos 400 kcal/día y 30 g o más de proteína al día, de acuerdo con la guía ESPEN, y deben acompañarse de seguimiento de tolerancia, adherencia, ingesta total, peso y funcionalidad.
- Si se identifica disfagia, dificultad para masticar, problemas dentales, dependencia para comer, tos durante la alimentación, atragantamiento, deshidratación, pérdida acelerada de peso o imposibilidad del hogar para garantizar alimentación segura, se recomienda remitir a valoración clínica y nutricional, adaptar

consistencia y textura de alimentos, apoyar al cuidador durante las comidas y activar seguimiento estrecho.

- Si se identifica inseguridad alimentaria, falta de recursos para adquirir alimentos, soledad, abandono o incapacidad familiar para garantizar alimentación suficiente, se recomienda activar redes familiares, comunitarias, sociales o intersectoriales. La respuesta no debe limitarse a educación nutricional cuando el problema principal es el acceso material a alimentos.
- No se recomienda utilizar micronutrientes aislados como estrategia principal de abordaje nutricional temprano, salvo que exista déficit específico, indicación clínica o criterio profesional que lo justifique. La evidencia disponible no respalda la suplementación aislada de micronutrientes como intervención suficiente para modificar fragilidad, función o deterioro nutricional en personas mayores comunitarias.

9.3.2 Dimensión cognitiva y mental

- Si la persona mayor no presenta queja cognitiva, cambios funcionales ni señales de alteración mental, se recomienda promover envejecimiento cognitivo saludable mediante actividad física regular, participación social, sueño adecuado, alimentación saludable, control de factores de riesgo vascular, uso de lentes o audífonos cuando se requieran, reducción de aislamiento y vigilancia periódica de cambios en memoria, conducta o funcionalidad.
- Si la persona mayor, la familia o el cuidador reportan queja de memoria, olvidos frecuentes, dificultad para manejar medicamentos, citas, dificultades económicas: dificultad de acceso efectivo a trasporte, garantía de acceso a servicios de salud, preparación de alimentos o tareas cotidianas, se recomienda realizar entrevista a la persona mayor y a un informante calificado, observar la vida cotidiana en el hogar y aplicar una prueba breve de tamización cognitiva si el equipo cuenta con entrenamiento. El resultado debe utilizarse para orientar decisiones de seguimiento o remisión, no para diagnosticar demencia en el hogar.
- Si se identifica riesgo aumentado o deterioro cognitivo leve probable con funcionalidad conservada, se recomienda iniciar intervenciones domiciliarias no farmacológicas y multidominio: estimulación cognitiva, entrenamiento de memoria y atención, actividad física segura, rutinas compensatorias, uso de calendarios, listas visibles,

recordatorios de citas, organización de medicamentos, lectura guiada, conversación estructurada, actividades significativas, participación familiar, intervención nutricional cuando aplique y reducción del estrés.

- Si la persona mayor presenta deterioro cognitivo leve probable o pérdida incipiente de funcionalidad, se recomienda formular un plan familiar con metas concretas, participación del cuidador, ayudas externas de memoria, simplificación de rutinas, entrenamiento en actividades de la vida diaria, revisión de seguridad del hogar y coordinación con el nivel primario para valoración clínica. La intervención debe orientarse a preservar autonomía, seguridad y funcionamiento cotidiano.
- Si se identifica depresión, ansiedad, aislamiento severo, pérdida de interés, trastornos del sueño, desesperanza o deterioro del ánimo, se recomienda valorar severidad, revisar causas asociadas —dolor, duelo, enfermedad crónica, soledad, polifarmacia, deterioro sensorial o dependencia—, brindar apoyo psicoeducativo inicial, fortalecer redes familiares y comunitarias, y activar ruta de salud mental cuando los síntomas sean persistentes, severos o generen deterioro funcional.
- Si se presenta confusión aguda, desorientación de inicio reciente, somnolencia marcada, agitación no habitual, alucinaciones, cambio brusco de conducta, deterioro rápido de memoria, abandono del autocuidado, errores peligrosos con medicamentos, caídas asociadas a confusión o incapacidad del cuidador para sostener el cuidado, se recomienda activar valoración clínica prioritaria para descartar delirium, infección, deshidratación, evento adverso por medicamentos, depresión severa u otra causa potencialmente reversible. En estos casos no se debe iniciar entrenamiento cognitivo domiciliario como acción principal antes de la valoración clínica.
- Si se identifica ideación suicida, riesgo de autolesión, violencia, negligencia grave o incapacidad familiar para proteger a la persona mayor, se recomienda activar de manera inmediata la ruta de urgencias, salud mental, protección social o autoridad competente según el contexto y severidad.

9.3.3 Dimensión física-funcional

- Si la persona mayor presenta riesgo bajo o prefragilidad, se recomienda iniciar o reforzar ejercicio funcional estructurado con énfasis en movilidad, fuerza, equilibrio, marcha y actividades

cotidianas. El plan debe adaptarse a capacidad física, preferencias, seguridad del hogar, comorbilidades y disponibilidad de apoyo familiar.

- Si la persona mayor presenta fragilidad, disminución de movilidad, dificultad para levantarse de la silla, marcha lenta, bajo desempeño físico o pérdida funcional incipiente, se recomienda priorizar intervenciones multicomponente y supervisadas, que incluyan entrenamiento de fuerza o resistencia, equilibrio, movilidad, marcha, transferencias y práctica de actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. El acompañamiento profesional presencial o remoto debe usarse para ajustar intensidad, seguridad y adherencia.
- Si la persona mayor presenta antecedente de caída, caídas recurrentes, miedo intenso a caer, alteración de la marcha, dificultad para transferirse o alto riesgo de caída, se recomienda realizar evaluación del entorno hogar y modificar riesgos ambientales. Deben revisarse baño, pasillos, iluminación, pisos, obstáculos, tapetes, escaleras, calzado, cama, silla y apoyos para levantarse. Esta intervención debe focalizarse en personas con riesgo aumentado; no se recomienda como acción universal aislada para todas las personas mayores sin identificación de riesgo.
- Si se identifica fragilidad o pérdida funcional asociada a riesgo nutricional, se recomienda combinar intervención física-funcional con intervención nutricional, especialmente consejería dietaria, fortalecimiento de ingesta proteico-energética y suplementación selectiva cuando esté indicada. La nutrición aislada no debe reemplazar el ejercicio multicomponente cuando el problema principal es fragilidad física o deterioro funcional.
- No se recomienda que el ejercicio domiciliario completamente no supervisado sea la estrategia principal en personas mayores con fragilidad, deterioro funcional o alto riesgo de caída. La evidencia sugiere menor efectividad de los programas exclusivamente autoguiados; por tanto, se debe incorporar supervisión, seguimiento, educación al cuidador o monitoreo remoto cuando sea posible.
- No se recomienda utilizar visitas preventivas generales, educación aislada o entrega de información sin componente activo de ejercicio, movilidad, adaptación del entorno o seguimiento, como estrategia central para prevenir deterioro físico-funcional o caídas.

9.3.4 Polifarmacia y seguridad farmacológica

- Si la persona mayor usa cuatro o más medicamentos de manera regular, tiene múltiples prescriptores, dificultades para administrar el tratamiento, mala adherencia, automedicación, duplicidades, caídas, confusión, mareo, somnolencia o sospecha de evento adverso, se recomienda realizar revisión estructurada de medicamentos y coordinar ajustes con el médico, enfermería, farmacia o equipo clínico responsable.
- La revisión de medicamentos debe orientarse a identificar medicamentos potencialmente inapropiados, posibles omisiones de prescripción, duplicidades, interacciones, efectos adversos, complejidad del régimen, barreras de comprensión, dificultades visuales, cognitivas o manuales para administrar medicamentos, y capacidad real del cuidador o familia para apoyar el tratamiento.
- No se recomienda formular la intervención como "reducir medicamentos" de manera general. La acción debe orientarse a optimizar la farmacoterapia, diferenciando polifarmacia apropiada de polifarmacia inapropiada, y evitando suspensiones sin valoración clínica o sin coordinación con el prescriptor.
- Si se sospecha evento adverso por medicamentos, confusión asociada a medicación, caída posterior a cambio terapéutico, somnolencia marcada, hipotensión, mareo, duplicidad, sobredosis, uso incorrecto o imposibilidad familiar de administrar adecuadamente el tratamiento, se recomienda remisión o revisión clínica prioritaria.
- El equipo puede evaluar la adherencia apoyándose en instrumentos como el test de Morisky-Green, y priorizar para valoración por medicina familiar o geriatría a las personas con multimorbilidad, plurisintomatología, seguimiento por múltiples especialidades o efectos adversos de medicamentos, dado que la deprescripción exige entrenamiento específico.

9.3.5 Violencia, maltrato, negligencia y sobrecarga del cuidador

- En toda visita domiciliaria a familias con persona mayor dependiente, frágil, aislada o con deterioro cognitivo o funcional, se recomienda explorar de manera segura y respetuosa la presencia de maltrato físico, psicológico, financiero, sexual, negligencia, abandono, restricción indebida de autonomía, violencia patrimonial, explotación económica, discriminación por edad, sobrecarga del

cuidador, conflicto familiar, dependencia sin relevo o aislamiento social.

- Ante cualquier tipo de violencia se debe activar la ruta municipal de atención al maltrato de la persona mayor.
- Si se identifican señales de sobrecarga del cuidador, agotamiento, ansiedad, depresión, dificultad para resolver problemas, comunicación conflictiva o prácticas de cuidado inseguras, se recomienda brindar educación y entrenamiento familiar en habilidades de cuidado, autocuidado, comunicación, afrontamiento, manejo del estrés, resolución de problemas y uso de redes de apoyo.
- Si se identifica violencia, negligencia grave, abandono, explotación económica, riesgo para la vida o incapacidad del hogar para sostener cuidado seguro, se recomienda activar de inmediato rutas de protección, salud mental, trabajo social, redes comunitarias, autoridades competentes o servicios de salud según severidad. La respuesta no debe limitarse a educación familiar cuando existe daño o riesgo de daño.

9.4 Pautas pregunta 3. Criterios de alarma y escalamiento

- En personas mayores en el entorno hogar, se recomienda considerar como criterios de alarma todos los hallazgos clínicos, funcionales, cognitivos, nutricionales, farmacológicos, ambientales o psicosociales que indiquen deterioro agudo, pérdida reciente de independencia, riesgo de evento adverso, inseguridad del entorno o incapacidad del hogar para sostener cuidado seguro.
- Si se identifica caída reciente, caídas repetidas, miedo intenso a caer, dificultad nueva para caminar, levantarse o transferirse, pérdida reciente de independencia en actividades básicas o instrumentales, marcha claramente enlentecida o deterioro rápido de movilidad, se recomienda remitir a valoración clínica y funcional, activar fisioterapia o rehabilitación según disponibilidad, valorar riesgo de caída y revisar seguridad del entorno hogar.
- Si se identifica confusión aguda, desorientación reciente, cambio brusco de conducta, somnolencia o agitación no habitual, deterioro rápido de memoria, abandono del autocuidado, errores peligrosos con medicamentos, alucinaciones o caídas asociadas a confusión, se recomienda remisión prioritaria para valoración médica, con el

fin de descartar delirium, infección, deshidratación, evento adverso farmacológico, trastorno metabólico, depresión severa u otra causa potencialmente reversible.

- Si se identifica depresión severa, ideación suicida, riesgo de autolesión, desesperanza marcada, aislamiento extremo o incapacidad del cuidador/familia para manejar cambios mentales o conductuales, se recomienda activar ruta de salud mental o urgencias según severidad, y no dejar el caso únicamente con consejería familiar.
- Si se identifica pérdida involuntaria de peso, baja ingesta persistente, pérdida de apetito, deshidratación, disfagia, dificultad para masticar, dependencia para comer, inseguridad alimentaria, malnutrición asociada a fragilidad o deterioro funcional, se recomienda remitir a valoración nutricional y médica, iniciar intervención alimentaria, activar apoyo familiar o social y realizar seguimiento estrecho.
- Si se identifica polifarmacia problemática, errores de administración, duplicidad terapéutica, automedicación riesgosa, mala adherencia persistente, mareo, caídas, somnolencia o confusión posterior a cambios de medicación, se recomienda realizar revisión prioritaria de medicamentos y coordinar con médico, enfermería o farmacia. Si existe sospecha de evento adverso grave, se debe activar valoración clínica inmediata.
- Si se identifica dolor agudo o no controlado, fiebre persistente, disnea, síncope, deterioro súbito del estado general, infección probable, descompensación de enfermedad crónica o signos clínicos que superen la capacidad resolutiva del equipo domiciliario, se recomienda remisión clínica o activación de urgencias según severidad.
- Si se identifican barreras físicas graves, alto riesgo ambiental de caídas, ausencia de baño seguro, falta de agua segura, saneamiento básico insuficiente, hacinamiento, imposibilidad de cumplir prácticas básicas de cuidado o condiciones materiales que comprometan la seguridad, se recomienda activar intervenciones sobre el entorno, rutas sociales o intersectoriales y seguimiento del plan familiar.
- Si la persona mayor vive sola y presenta dependencia, deterioro cognitivo, fragilidad, malnutrición, alto riesgo de caída o imposibilidad de autocuidado, se recomienda activar red familiar, comunitaria, la ruta institucional municipal a través del referente local de persona mayor, y definir un plan de seguimiento

intensificado. Entre las redes de cuidado a activar se incluye el enlace con los Centros Vida, con reorientación de sus intervenciones hacia el entrenamiento cognitivo y la prevención o intervención de la fragilidad y la sarcopenia.

- Si se identifica cuidador sobrecargado, ausencia de relevo, disfuncionalidad familiar severa, violencia, negligencia, abandono o imposibilidad del hogar para sostener cuidado seguro, se recomienda activar redes de apoyo, rutas de protección, trabajo social, salud mental o servicios de salud según el hallazgo y la gravedad.
- Si se acumulan varias señales moderadas de riesgo en diferentes dominios —por ejemplo, pérdida de peso, marcha lenta, polifarmacia, queja cognitiva y cuidador sobrecargado—, aunque ninguna constituya por sí sola una urgencia, se recomienda activar valoración geriátrica integral ampliada y plan de cuidado intensificado, dado que la acumulación de vulnerabilidades aumenta el riesgo de deterioro y eventos adversos.

9.5 Pautas pregunta 4.

- No se recomienda implementar visitas domiciliarias preventivas universales, repetitivas o inespecíficas como estrategia suficiente para mantener funcionalidad, autonomía, participación social o cuidado seguro. La evidencia muestra beneficios inconsistentes cuando las visitas no están diferenciadas por riesgo, no tienen contenido estructurado o no se articulan a un plan de cuidado. En el contexto colombiano, la Ley 1276 de 2009 estableció los Centros Vida como modalidad de atención integral a las personas mayores, junto con los centros de bienestar del adulto mayor; sin embargo, no todos los municipios del departamento cuentan con esta oferta, por lo que la visita domiciliaria estructurada y diferenciada por riesgo constituye una herramienta relevante para el territorio. La implementación de la pauta debe considerar la oferta institucional existente en cada municipio y su articulación con el PICF.
- Si la persona mayor presenta fragilidad, multimorbilidad, deterioro funcional, riesgo de caída, riesgo nutricional, queja cognitiva, polifarmacia problemática, aislamiento, sobrecarga del cuidador o vulnerabilidad social, se recomienda implementar un esquema de seguimiento domiciliario estructurado, proporcional al riesgo y articulado con servicios de salud, apoyo familiar y redes comunitarias.

- Todo esquema de seguimiento domiciliario debe incluir, como mínimo: valoración inicial, clasificación de riesgo, definición de problemas prioritarios, metas de cuidado, responsables, compromisos familiares, intervenciones por dominio, rutas activadas, fecha o mecanismo de seguimiento, criterios de alarma y verificación del cierre efectivo de remisiones.
- Se recomienda definir un responsable de seguimiento o coordinador del caso dentro del equipo, encargado de integrar la información, revisar cumplimiento del plan, coordinar con servicios de salud, verificar activación de redes y ajustar la intensidad del acompañamiento según evolución.
- En personas con riesgo bajo, sin fragilidad ni deterioro funcional, cognitivo, nutricional o social relevante, se recomienda seguimiento orientado a promoción, educación familiar, vigilancia de signos de alarma, fortalecimiento de actividad física, alimentación saludable, participación social, adherencia terapéutica y mantenimiento de redes de apoyo. La periodicidad debe definirse según criterio del equipo y programación territorial del PICF.
- En personas con riesgo moderado o fragilidad incipiente, se recomienda seguimiento activo del plan de cuidado, con verificación de funcionalidad, movilidad, peso, ingesta, estado cognitivo/mental, adherencia a medicamentos, seguridad del hogar, carga del cuidador y cumplimiento de compromisos familiares. Si aparece deterioro o no se cumplen metas, se debe intensificar la valoración o activar servicios.
- En personas con alto riesgo, fragilidad establecida, pérdida funcional, caídas, malnutrición, deterioro cognitivo, polifarmacia problemática, soledad, violencia o incapacidad familiar para sostener el cuidado, se recomienda seguimiento intensificado, coordinación con nivel primario, rehabilitación, nutrición, salud mental, farmacia, trabajo social o redes comunitarias según necesidad. El plan debe tener responsables definidos y verificación de que la remisión o articulación se haya concretado.
- Si la persona mayor presenta deterioro físico-funcional potencialmente reversible o pérdida reciente de independencia, se recomienda considerar un enfoque de readaptación funcional o reablement, entendido como un servicio domiciliario temporal, centrado en metas, orientado a recuperar independencia y con participación interdisciplinaria. Esta acción debe aplicarse con prudencia, dado que la certeza de la evidencia es baja o muy baja,

pero puede ser pertinente cuando existe posibilidad de recuperación funcional.

- Si se activa una remisión a servicios de salud, rehabilitación, nutrición, salud mental, trabajo social o protección, se recomienda que el equipo haga seguimiento del cierre efectivo de la remisión. No debe considerarse cumplida la acción únicamente con entregar la indicación o registrar la necesidad.
- Si se identifican barreras de acceso geográfico, económico, administrativo o familiar que impiden el cumplimiento del plan, se recomienda activar apoyo familiar, comunitario, institucional o intersectorial, y ajustar el plan a la capacidad real del hogar y del territorio.
- El seguimiento debe monitorear, como mínimo, funcionalidad, movilidad, caídas, peso o ingesta, estado cognitivo/mental, medicamentos, eventos adversos, hospitalizaciones, urgencias, participación social, carga del cuidador, seguridad del entorno y cumplimiento de compromisos familiares.
- Si durante el seguimiento se identifica empeoramiento funcional, caída, pérdida de peso, deterioro cognitivo o mental, evento adverso por medicamentos, maltrato, negligencia, hospitalización reciente o incapacidad del cuidador, se recomienda reclasificar el riesgo, actualizar el plan de cuidado y activar valoración o remisión según severidad.

9.6 Acciones integradoras para el plan de cuidado familiar

- Si la valoración inicial identifica necesidades en más de un dominio, se recomienda formular un plan de cuidado familiar integrado, evitando planes fragmentados por dimensión. Por ejemplo, una persona mayor con marcha lenta, pérdida de peso y queja de memoria debe recibir una intervención que combine ejercicio funcional, abordaje nutricional, tamización cognitiva, revisión de medicamentos, apoyo del cuidador y seguimiento.
- Si la persona mayor presenta fragilidad o riesgo aumentado, se recomienda que el plan de cuidado sea concertado con la persona, la familia y el cuidador, incorporando preferencias, metas funcionales, actividades significativas, capacidades reales del hogar y apoyos disponibles.

- Si el hogar no cuenta con condiciones suficientes para sostener el cuidado seguro, se recomienda que el equipo no centre la intervención únicamente en educación individual. Deben activarse redes comunitarias, servicios sociales, rutas de protección, apoyo familiar ampliado o gestión intersectorial según el problema identificado.
- Si el equipo identifica necesidades que superan su capacidad resolutiva, se recomienda activar rutas de atención y mantener seguimiento del caso hasta verificar continuidad del cuidado. La visita domiciliaria no debe cerrarse sin definir responsable, ruta y próximo paso.

10. Referencias

1. Secretaria de salud de Boyacá. Análisis de la sitación de salud de la vigencia 2023. ASIS Boyacá 2023. Tunja; 2024.
2. Secretaria de Salud de Boyacá. Análisis de la situación de salud de la vigencia 2024. ASIS Boyacá 2024. Tunja; 2025.
3. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017 Sep 12;2017(9). doi:10.1002/14651858.CD006211.pub3
4. Secretaria de Salud de Boyacá. Informe trimestral de indicadores SIBACOM. Tunja; 2025 Jul.
5. Briggs R, McDonough A, Ellis G, Bennett K, O'Neill D, Robinson D. Comprehensive Geriatric Assessment for community-dwelling, high-risk, frail, older people. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2022. doi:10.1002/14651858.CD012705.pub2
6. Hayes C, Yigezu A, Dillon S, Fitzgerald C, Manning M, Leahy A, et al. Home-Based Comprehensive Geriatric Assessment for Community-Dwelling, At-Risk, Frail Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Geriatrics Society. John Wiley and Sons Inc; 2025. p. 1929–39. doi:10.1111/jgs.19402 PubMed PMID: 39964054.
7. Sum G, Nicholas SO, Nai ZL, Ding YY, Tan WS. Health outcomes and implementation barriers and facilitators of comprehensive

geriatric assessment in community settings: a systematic integrative review [PROSPERO registration no.: CRD42021229953]. BMC Geriatr. 2022 May;22(1):379. doi:10.1186/s12877-022-03024-4

8. Veronese N, Custodero C, Demurtas J, Smith L, Barbagallo M, Maggi S, et al. Comprehensive geriatric assessment in older people: An umbrella review of health outcomes. Age and Ageing. Oxford University Press; 2022. doi:10.1093/ageing/afac104 PubMed PMID: 35524746.

9. Apóstolo J, Cooke R, Bobrowicz-Campos E, Santana S, Marcucci M, Cano A, et al. Predicting risk and outcomes for frail older adults: An umbrella review of frailty screening tools. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. Joanna Briggs Institute; 2017. p. 1154–208. doi:10.11124/JBISRIR-2016-003018 PubMed PMID: 28398987.

10. G K. Frailty Defined by FRAIL Scale as a Predictor of Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis. J Am Med Dir Assoc. 2018 May;19(6):480–3. doi:10.1016/j.jamda.2018.04.006

11. Lee L, Patel T, Hillier LM, Maulkhan N, Slonim K, Costa A. Identifying frailty in primary care: A systematic review. Geriatrics and Gerontology International. Blackwell Publishing; 2017. p. 1358–77. doi:10.1111/ggi.12955 PubMed PMID: 28401737.

12. Craig C, Chadborn N, Sands G, Tuomainen H, Gladman J. Systematic review of EASY-care needs assessment for community-dwelling older people. Age and Ageing. Oxford University Press; 2015. p. 559–65. doi:10.1093/ageing/afv050 PubMed PMID: 25911539.

13. Ruiz JG, Dent E, Morley JE, Merchant RA, Beilby J, Beard J, et al. Screening for and Managing the Person with Frailty in Primary Care: ICFSR Consensus Guidelines. Journal of Nutrition, Health and Aging. 2020. doi:10.1007/s12603-020-1492-3 PubMed PMID: 33155616.

14. O'Caoimh R, Cornally N, Weathers E, O'Sullivan R, Fitzgerald C, Orfila F, et al. Risk prediction in the community: A systematic review of case-finding instruments that predict adverse healthcare outcomes in community-dwelling older adults. Maturitas. Elsevier Ireland Ltd; 2015. p. 3–21.

doi:10.1016/j.maturitas.2015.03.009 PubMed PMID: 25866212.

15. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Hooper L, Kiesswetter E, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 2022 Apr 1;41(4):958–89. doi:10.1016/j.clnu.2022.01.024 PubMed PMID: 35306388.

16. Beck Jepsen D, Robinson K, Ogliari G, Montero-Odasso M, Kamkar N, Ryg J, et al. Predicting falls in older adults: an umbrella review of instruments assessing gait, balance, and functional mobility. BMC Geriatr. 2022 Dec 1;22(1). doi:10.1186/s12877-022-03271-5 PubMed PMID: 35879666.

17. Garrard JW, Cox NJ, Dodds RM, Roberts HC, Sayer AA. Comprehensive geriatric assessment in primary care: a systematic review. Aging Clinical and Experimental Research. Springer; 2020. p. 197–205. doi:10.1007/s40520-019-01183-w PubMed PMID: 30968287.

18. Phillips BNutrDiet MB, Foley AL, Barnard MEd R, Isenring EA, Miller MD. Nutritional screening in community-dwelling older adults: a systematic literature review. Asia Pac J Clin Nutr. 2010.

19. Mareschal J, Genton L, Collet TH, Graf C. Nutritional intervention to prevent the functional decline in community-dwelling older adults: A systematic review. Nutrients. MDPI AG; 2020. p. 1–21. doi:10.3390/nu12092820 PubMed PMID: 32942634.

20. Khor PY, Vearing RM, Charlton KE. The effectiveness of nutrition interventions in improving frailty and its associated constructs related to malnutrition and functional decline among community-dwelling older adults: A systematic review. Journal of Human Nutrition and Dietetics. John Wiley and Sons Inc; 2022. p. 566–82. doi:10.1111/jhn.12943 PubMed PMID: 34494314.

21. Bernal GB, General S, Bautista NE. Valoración nutricional en la persona adulta mayor. [Internet]. 2021. Available from: www.minsalud.gov.co

22. Abellan Van Kan G, Rolland Y, Andrieu S, Bauer J, Beauchet O, Bonnefoy M, et al. Gait speed at usual pace as a predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an International Academy on Nutrition and Aging (IANA) task

force. Journal of Nutrition, Health and Aging. 2009;13(10):881–9. doi:10.1007/s12603-009-0246-z PubMed PMID: 19924348.

23. Beishon LC, Elliott E, Hietamies TM, Mc Ardle R, O'Mahony A, Elliott AR, et al. Diagnostic test accuracy of remote, multidomain cognitive assessment (telephone and video call) for dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2022. doi:10.1002/14651858.CD013724.pub2 PubMed PMID: 35395108.

24. Burton JK, Stott DJ, McShane R, Noel-Storr AH, Swann-Price RS, Quinn TJ. Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) for the early detection of dementia across a variety of healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2021. doi:10.1002/14651858.CD011333.pub3 PubMed PMID: 34275145.

25. Martínez de la Iglesiaa J, DueñasHerrerob R, Carmen Onís Vilchesa M, Aguado Tabernéa C, Albert Colomerc C, Luque Luquec R. Adaptación y validación al castellano del cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ) para detectar la existencia de deterioro cognitivo en personas mayores e 65 años. Med Clin (Barc). 2001 Jan;117(4):129–34. doi:10.1016/S0025-7753(01)72040-4

26. Zou C, Amos-Richards D, Jagannathan R, Kulshreshtha A. Effect of home-based lifestyle interventions on cognition in older adults with mild cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatr. 2024 Dec 1;24(1). doi:10.1186/s12877-024-04798-5 PubMed PMID: 38413870.

27. Treacy D, Hassett L, Schurr K, Fairhall NJ, Cameron ID, Sherrington C. Mobility training for increasing mobility and functioning in older people with frailty. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2022. doi:10.1002/14651858.CD010494.pub2 PubMed PMID: 35771806.

28. Chase JAD, Phillips LJ, Brown M. Physical activity intervention effects on physical function among community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis. Journal of Aging and Physical Activity. Human Kinetics Publishers Inc.; 2017. p. 149–70. doi:10.1123/japa.2016-0040 PubMed PMID: 27620705.

29. Neil-Sztramko SE, Teggart K, Moore C, Sherifali D, Fitzpatrick-Lewis D, Coletta G, et al. Community-based group physical activity and/or nutrition interventions to promote mobility in older adults: an umbrella review. BMC Geriatr. 2022 Dec 1;22(1). doi:10.1186/s12877-022-03170-9 PubMed PMID: 35768770.

30. Sirikul W, Buawangpong N, Pinyopornpanish K, Siviroj P. Impact of multicomponent exercise and nutritional supplement interventions for improving physical frailty in community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics. BioMed Central Ltd; 2024. doi:10.1186/s12877-024-05551-8 PubMed PMID: 39558234.

31. Money A, MacKenzie A, Parchment A, Norman G, Harris D, Ahmed S, et al. Evidence on non-pharmacological interventions for preventing or reversing physical frailty in community-dwelling older adults aged over 50 years: overview of systematic reviews. BMC Geriatrics. BioMed Central Ltd; 2025. doi:10.1186/s12877-025-05768-1 PubMed PMID: 40097929.

32. Guan Y, Hu Z, Wang Q, Ou R, Xue H, Du W, et al. Effectiveness of interventions to improve frailty among community-dwelled older adults: A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics. Elsevier Ireland Ltd; 2025. doi:10.1016/j.archger.2025.105946 PubMed PMID: 40669122.

33. Yao G, Li F, Ma X, Wan X, Yang Y, Xu Y, et al. Effectiveness of Home-Based interventions for older adults with frailty or pre-frailty: a systematic review and meta-analysis. Archives of Gerontology and Geriatrics. Elsevier Ireland Ltd; 2026. doi:10.1016/j.archger.2025.106083 PubMed PMID: 41242035.

34. Liang IJ, Perkin OJ, McGuigan PM, Spellanzon B, Robb M, Liu CY, et al. The effectiveness of unsupervised home-based exercise for improving lower extremity physical function in older adults in Western and Eastern cultures: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics. BioMed Central Ltd; 2024. doi:10.1186/s12877-024-05393-4 PubMed PMID: 39354428.

35. Clemson L, Stark S, Pighills AC, Fairhall NJ, Lamb SE, Ali J, et al. Environmental interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2023. doi:10.1002/14651858.CD013258.pub2 PubMed PMID: 36893804.

36. Cheng P, Tan L, Ning P, Li L, Gao Y, Wu Y, et al. Comparative effectiveness of published interventions for elderly fall prevention: A systematic review and network meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI; 2018. doi:10.3390/ijerph15030498 PubMed PMID: 29534531.

37. Montero-Odasso M, van der Velde N, Martin FC, Petrovic M, Tan MP, Ryg J, et al. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age Ageing. 2022 Sep 2;51(9). doi:10.1093/ageing/afac205

38. M W, N B, L C, E B, H HH, C B, et al. Feasibility and Effectiveness of Intervention Programmes Integrating Functional Exercise into Daily Life of Older Adults: A Systematic Review. Gerontology. 2018;64(2):172–87. doi:10.1159/000479965

39. Mayo-Wilson E, Grant S, Burton J, Parsons A, Underhill K, Montgomery P. Preventive home visits for mortality, morbidity, and institutionalization in older adults: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. Public Library of Science; 2014. doi:10.1371/journal.pone.0089257 PubMed PMID: 24622676.

40. Drahota A, Udell JE, Mackenzie H, Pugh MT. Psychological and educational interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2024. doi:10.1002/14651858.CD013480.pub2 PubMed PMID: 39360568.

41. Olanrewaju O, Kelly S, Cowan A, Brayne C, Lafortune L. Physical activity in community dwelling older people: A systematic review of reviews of interventions and context. PLoS One. 2016 Dec 1;11(12). doi:10.1371/journal.pone.0168614 PubMed PMID: 27997604.

42. Van Schooten KS, Steffens D, Engeler A, Letton M, Brown A, Perram A, et al. Remote assessment of physical function in older people: feasibility, safety and agreement with in-person administration. Age Ageing. 2025 Sep 1;54(9). doi:10.1093/ageing/afaf266 PubMed PMID: 41014506.

43. Cole JA, Gonçalves-Bradley DC, Alqahtani M, Barry HE, Cadogan C, Rankin A, et al. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023 Oct 11;2023(10).

doi:10.1002/14651858.CD008165.pub5 PubMed PMID: 37818791.

44. Pabón-Poches DK, Cervantes-Henríquez ML, Barchelot-Aceros LJ, Delgado-Meza JA. Intervención del maltrato hacia las personas mayores en el contexto familiar: una revisión sistemática. MedUNAB. 2025 Nov 30;28(2). doi:10.29375/01237047.5163

45. Wróblewska Z, Chmielewski J, Florek-Łuszczki M, Nowak-Starz G, Wojciechowska M, Wróblewska I. Assessment of functional capacity of the elderly. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2023 May;30(1):156–63. doi:10.26444/aaem/161775

46. Crocker TF, Lam N, Ensor J, Jordão M, Bajpai R, Bond M, et al. Community-based complex interventions to sustain independence in older people, stratified by frailty: A systematic review and network meta-analysis. Health Technol Assess (Rockv). 2024 Aug 1;28(48). doi:10.3310/HNRP2514 PubMed PMID: 39252602.

47. Morgado B, Silva C, Agostinho I, Brás F, Amaro P, Lusquinhos L, et al. Psychotherapeutic Interventions for Depressive Symptoms in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review with Meta-Analysis. Healthcare (Switzerland). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); 2024. doi:10.3390/healthcare12242551

48. Kim M, Shin E, Kim S, Sok S. The Effectiveness of Multicomponent Intervention on Daily Functioning among the Community-Dwelling Elderly: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI; 2022. doi:10.3390/ijerph19127483 PubMed PMID: 35742730.

49. Secretaria de Salud de Boyacá. LINEAMIENTO TÉCNICO PICF 2025. 2025.

50. M van Haastregt JC, M Diederiks JP, van Rossum E, de Witte LP, J M Crebolder HF. General practice Effects of preventive home visits to elderly people living in the community: systematic review [Internet]. 2000. Available from: www.bmj.com

51. Bouman A, van Rossum E, Evers S, Ambergen T, Kempen G, Knipschild P. Multidimensional Geriatric Assessment: Back to the Future Effects on Health Care Use and Associated Cost of a

Home Visiting Program for Older People With Poor Health Status: A Randomized Clinical Trial in the Netherlands. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Mar 1;63(3):291–7. doi:10.1093/gerona/63.3.291

52. Cochrane A, Furlong M, Mcgilloway S, Molloy DW, Stevenson M, Donnelly M. Time-limited home-care reablement services for maintaining and improving the functional independence of older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2016. doi:10.1002/14651858.CD010825.pub2 PubMed PMID: 27726122.

11. Anexos

11.1 Anexo 1. Ecuaciones de búsqueda

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda Pubmed/Embase
¿Cuáles son las estrategias/instrumentos más adecuados para clasificar riesgo de la persona mayor en hogar las dimensiones: mental, cognitiva, física-funcional y nutricional para guiar decisiones en el marco del abordaje en el entorno hogar?	Evaluación / clasificación de riesgo	P: personas mayores en entorno hogar/comunidad, atendidas en nivel primario. I: instrumentos o estrategias de valoración integral y estratificación del riesgo. C: otra herramienta, valoración usual o ausencia de instrumento. O: capacidad para clasificar riesgo clínico, funcional, mental, social y ambiental; utilidad para decisiones en APS.	older adults, aged, elderly, community-dwelling, home care, primary health care, comprehensive geriatric assessment, risk assessment, frailty, functional assessment, cognitive assessment, nutritional assessment, falls, social risk, caregiver burden	("Aged" OR "Older Adults" OR elderly OR "older person*" OR "persona mayor" OR "adulto mayor") AND ("Home Care Services" OR home-based OR home OR household OR "community-dwelling" OR "entorno hogar") AND ("Primary Health Care" OR "primary care" OR "atención primaria" OR "nivel primario") AND ("Risk Assessment" OR "risk stratification" OR screening OR "Comprehensive Geriatric Assessment" OR frailty OR "frailty assessment" OR functional OR cognition OR nutritional OR "fall risk" OR "social risk" OR caregiver) AND (guideline* OR "practice guideline" OR "systematic review" OR consensus)

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda Pubmed/Embase
En personas mayores en el entorno hogar, ¿qué acciones e intervenciones iniciales, estratificadas según nivel de riesgo, han mostrado efectividad y factibilidad para el abordaje temprano de alteraciones en las dimensiones mental, nutricional, cognitiva y física-funcional?	Supreguntas: ¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión mental? ¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión nutricional? ¿Qué acciones e	P: personas mayores en entorno hogar, con distintos perfiles de riesgo, y sus cuidadores/familias. I: intervenciones iniciales domiciliarias o basadas en el hogar. C: atención usual, ninguna intervención, u otra intervención. O: funcionalidad, calidad de vida, caídas, hospitalización, eventos adversos, carga del cuidador, factibilidad, aceptabilidad.	home-based interventions, home visit, elderly care, frailty, exercise, rehabilitation, caregiver support, medication review, nutrition, fall prevention, self-management, home modification, feasibility, acceptability	("Aged" OR elderly OR "older adult*" OR "persona mayor" OR "adulto mayor") AND ("Home Care Services" OR home-based OR domiciliary OR household OR "entorno hogar") AND ("Primary Health Care" OR "primary care") AND (intervention* OR program* OR "care plan*" OR education OR counseling OR exercise OR rehabilitation OR "medication review" OR nutrition OR "fall prevention" OR "caregiver support" OR "home modification") AND (effectiveness OR efficacy OR feasible OR feasibility OR acceptability OR implementation) AND (guideline* OR "systematic review" OR meta-analysis OR consensus)

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda Pubmed/Embase
	intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión cognitiva? ¿Qué acciones e intervenciones iniciales en el entorno hogar son efectivas y factibles, según el nivel de riesgo de la persona mayor, para el abordaje temprano de la dimensión física-funcional?			

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda Pubmed/Embase
En personas mayores en el entorno hogar con fragilidad o riesgo aumentado, ¿qué criterios de alarma y remisión oportuna permiten identificar deterioro clínico-funcional y activar servicios de salud o rutas de atención para prevenir eventos adversos, hospitalizaciones evitables e institucionalización?	Detección / seguridad / referencia	P: personas mayores atendidas en el hogar por APS, equipos territoriales o cuidadores. I: criterios de alarma, signos de deterioro y criterios de remisión/escalamiento. C: manejo habitual o ausencia de criterios explícitos. O: remisión oportuna, prevención de deterioro, hospitalización evitable y eventos adversos.	red flags, warning signs, deterioration, decompensation, referral criteria, escalation of care, avoidable hospitalization, patient safety, older adults, home care	("Aged" OR elderly OR "older adult*" OR "persona mayor" OR "adulto mayor") AND (home OR "home care" OR domiciliary OR household OR "entorno hogar") AND ("Primary Health Care" OR "primary care" OR "community health services") AND ("warning signs" OR "alarm signs" OR "red flags" OR deterioration OR decompensation OR "clinical worsening" OR referral OR "care escalation" OR triage OR "hospital admission") AND ("avoidable hospitalization" OR "adverse events" OR safety OR "functional decline") AND (guideline* OR "systematic review" OR consensus OR protocol*)
En personas mayores que viven en el entorno hogar, según su nivel de fragilidad o riesgo aumentado, ¿qué esquemas estructurados de seguimiento domiciliario y coordinación con servicios de salud, redes comunitarias y apoyo familiar son efectivos y factibles para mantener la funcionalidad, la autonomía, la	Organización del cuidado / continuidad / implementación	P: personas mayores y sus familias en entorno hogar, atendidas desde APS. I: seguimiento domiciliario estructurado, visitas periódicas, coordinación interprofesional y articulación con redes comunitarias. C: seguimiento no estructurado o cuidado usual. O: continuidad	follow-up, home visits, continuity of care, care coordination, case management, integrated care, community networks, social support, active ageing, healthy ageing	("Aged" OR elderly OR "older adult*" OR "persona mayor" OR "adulto mayor") AND ("Home Care Services" OR "home visit*" OR domiciliary OR "community-dwelling" OR "entorno hogar") AND ("Primary Health Care" OR "primary care") AND (follow-up OR monitoring OR "case management" OR "care coordination" OR "continuity of patient care" OR "integrated care" OR "community network*" OR "social support" OR referral OR linkage) AND ("active ageing" OR "healthy ageing" OR

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda Pubmed/Embase
participación social y el cuidado seguro, y para reducir eventos adversos, hospitalizaciones evitables e institucionalización?		del cuidado, vejez activa, seguridad, calidad de vida, permanencia en comunidad, menor uso evitable de servicios.		safety OR "safe care" OR "quality of life" OR hospitalization) AND (guideline* OR "systematic review" OR "best practice" OR consensus)

11.2 Anexo 2. Frail

Ítem	Dimensión	Pregunta adaptada al entorno rural	Puntaje
F	Fatiga	En las últimas 4 semanas, ¿se ha sentido cansado o sin fuerzas la mayor parte de los días, incluso para hacer sus oficios o actividades habituales?	Sí = 1 / No = 0
R	Resistencia	¿Se le dificulta subir una cuesta, una loma o varios escalones sin parar a descansar y sin que alguien le ayude?	Sí = 1 / No = 0
A	Deambulación	¿Se le dificulta caminar una distancia como ir hasta la tienda, la escuela, la iglesia, la casa de un vecino cercano o recorrer varias cuadras, sin ayuda de otra persona?	Sí = 1 / No = 0
I	Comorbilidad	¿Un médico o personal de salud le ha dicho que tiene cinco o más enfermedades, como presión alta, diabetes, enfermedad del corazón, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, cáncer, artritis u otras?	Sí = 1 / No = 0
L	Pérdida de peso	En el último año, ¿ha bajado de peso sin proponérselo, ha notado la ropa más floja o ha tenido que ajustar la correa, la falda o el pantalón? Si es posible, verificar con peso registrado.	Sí = 1 / No = 0

Interpretación del puntaje

Puntaje total	Clasificación	Interpretación operativa para el entorno hogar
0 puntos	Sin fragilidad identificada / robusto	No se identifican criterios de fragilidad por FRAIL. Se recomienda mantener promoción de salud, actividad física segura, alimentación adecuada, participación social, educación familiar y vigilancia periódica de signos de alarma.
1 a 2 puntos	Prefragilidad / riesgo aumentado	La persona mayor presenta señales iniciales de vulnerabilidad. Se recomienda valoración ampliada de causas modificables, revisión de nutrición, movilidad, medicamentos, estado cognitivo/mental, entorno y apoyo familiar. Debe formularse un plan preventivo y programar seguimiento.
3 a 5 puntos	Fragilidad probable	La persona mayor tiene alta probabilidad de fragilidad. Se recomienda activar valoración geriátrica integral ampliada, plan de cuidado familiar, revisión de riesgos clínicos, funcionales, nutricionales, cognitivos, farmacológicos y sociales, y seguimiento intensificado. Si hay signos de alarma, activar remisión o ruta correspondiente.

11.3 Anexo 3. Estratificación operativa y seguimiento

Nivel	Criterio general	Conducta	Seguimiento
Bajo Riesgo	Sin resultados positivos y sin señales de alarma	Promoción de envejecimiento saludable, autocuidado, prevención de caídas, nutrición y actividad física; educación familiar.	Seguimiento habitual del PICF.
Moderado riesgo	Uno o más dominios positivos sin alarma inmediata	Intervención dirigida al dominio, valoración clínica ampliada y articulación con recursos disponibles.	Seguimiento programado según problema y respuesta.
Alto riesgo	Deterioro importante, múltiples dominios comprometidos, dependencia creciente, sospecha de maltrato, delirium, riesgo suicida u otra alarma.	Valoración clínica prioritaria; activar remisión y coordinación interprofesional según necesidad.	Seguimiento estrecho y reevaluación hasta estabilización.

Criterios de alarma y remisión

- Alteración aguda del estado mental, sospecha de delirium o deterioro neurológico agudo.
- Ideación suicida, intento de suicidio, síntomas psicóticos o alteración psiquiátrica grave
- Caída con traumatismo relevante, incapacidad súbita para la marcha o deterioro funcional rápido.
- Deshidratación, pérdida de peso acelerada, imposibilidad para alimentarse o sospecha de malnutrición grave.
- Problemas relacionados con medicamentos con riesgo inmediato, sospecha de toxicidad o eventos adversos graves.
- Sospecha de maltrato, abandono o negligencia que comprometa seguridad o integridad.
- Ausencia de cuidador o red de apoyo cuando la persona no puede satisfacer necesidades básicas de manera autónoma.

- Signos de enfermedad aguda que requieran valoración médica prioritaria.